Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 6 : Santé Publique

Durée de l'épreuve : **45 minutes**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

La calculatrice est autorisée pendant l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 27 pages numérotées de 1 à 27 et comporte 37 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 6

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	13	25	37		
2	14	26	38		
3	15	27	39		
4	16	28	40		
5	17	29	41		
6	18	30	42		
7	19	31	43		
8	20	32	44		
9	21	33	45		
10	22	34			
11	23	35			
12	24	36			

A B C D E

Mot de votre RM

Hellooooooo les Piwan !!!!
J'espère que vous allez bien en ce début d'année (oui oui ce n'est que le début !). Déjà un grand BRAVO à vous d'avoir fini votre **premier** tuto !

Juste après ce petit message vous vous plongerez dans la correction du Tuto 1 de Santé Publique ! La Santé Publique est une matière où plus vous vous entrainerez, plus vous aurez des automatismes donc travaillez +++ la correction ! Bonne chance à vous pour la suite car je suis sûre que vous allez progresser à vitesse grand V !

Votre Recette Magique de SPeculoos

Question 1
Concernant la santé publique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité

B. Un indicateur de santé est un outil mesurant l'état de santé d'un individu

C. Les indicateurs servent à décrire, expliquer, estimer et prévoir

D. La démarche utilisée par John Snow pour trouver le mode de transmission du choléra illustre la démarche épidémiologique

E. Le réseau Sentinelles est composé de 1400 médecins généralistes et une centaine de pédiatres

Question 1

✔ **Item A** → *Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, ...*

On commence votre premier tuto de SP avec un item... 🥳 VRAIII !! L'item est assez long donc lisez bien jusqu'au bout, surtout que c'est une définition très importante ! Retenez que la santé est une mesure subjective. Elle n'est pas ressentie de la même manière par tous.

✘ **Item B** → *Un indicateur de santé est un outil mesurant l'état de santé d'un individu*

On y était presque mais nonn... Un indicateur de santé est un outil mesurant l'état de santé d'une population et non d'un individu.

✘ **Item C** → *Les indicateurs servent à décrire, expliquer, estimer et prévoir*

Encore une fois attention aux pièges !! C'est bien l'acronyme DEEP, mais c'est : Décrire, Expliquer, **ÉVALUER** et Prévoir.

✔ **Item D** → *La démarche utilisée par John Snow pour trouver le mode de transmission du choléra ...*

Ouii toutafé !! John Snow a pu cibler le problème. En effet, le choléra se transmettait par l'eau et non les miasmes comme ce qui a pu être pensé à l'époque.

✘ **Item E** → *Le réseau Sentinelles est composé de 1400 médecins généralistes et une centaine de ...*

Qui dit dernier item, dit dernier piège 🙈. Tout est vrai sauf que c'est 1300 médecins généralistes et non 1400. Ces pièges sont là pour que vous fassiez attention à tous les détails, courage ça va le faire. Vous êtes des goats 😌 !!!

Réponses vraies : A et D

Question 2
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Une proportion désigne le rapport d'un nombre de personnes atteintes d'un problème de santé sur l'effectif total de cette population

B. Un ratio désigne le rapport d'un numérateur et d'un dénominateur de même nature

C. Le taux n'est pas une notion dynamique

D. Le taux standardisé autorise les comparaisons entre plusieurs périodes et unités géographiques, mais pas entre les deux sexes

E. Une proportion s'exprime en pourcentage

Question 2

✔ **Item A** → *Une proportion désigne le rapport d'un nombre de personnes atteintes d'un …*

Tout à fait ! C'est la définition même du cours on commence chill 😉.

✘ **Item B** → *Un ratio désigne le rapport d'un numérateur et d'un dénominateur de même nature*

Attention à ne pas cocher les cases trop vite !! Le numérateur et le dénominateur doivent être de nature différente. On peut citer l'exemple du *sexe ratio* qui fait le rapport du nombre d'hommes sur le nombre de femmes au sein d'un groupe étudié.

✘ **Item C** → *Le taux n'est pas une notion dynamique*

Au contraire !! Le taux **prend en compte le temps** sur des périodes données ce qui en fait une notion **dynamique**.

✘ **Item D** → *Le taux standardisé autorise les comparaisons entre plusieurs périodes et unités …*

Aïe aïe aïe c'est quoi cette fin… Le taux standardisé permet bien de comparer n'importe quels groupes entre eux, quelles que soient les caractéristiques qui les différencient.

✔ **Item E** → *Une proportion s'exprime en pourcentage*

Oui complètement !

Réponses vraies : A et E

Question 3
À propos des différents types d'épidémiologies, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Un des objectifs de l'épidémiologie descriptive est de formuler des hypothèses épistémologiques

B. L'épidémiologie analytique permet d'estimer le lien et la force de l'association entre l'exposition à certains facteurs et la survenue ultérieure de maladie

C. Les programmes d'assainissement rural et d'approvisionnement en eau potable de l'UNICEF au Bangladesh avaient pour but d'éliminer l'arsenic présent dans les puits

D. L'étude de Framingham a été conduite sur une seule génération

E. L'épidémiologie évaluative permet d'évaluer l'efficacité d'interventions thérapeutiques pharmacologiques et non-pharmacologiques uniquement

Question 3

✘ **Item A** → *Un des objectifs de l'épidémiologie descriptive est de formuler des hypothèses …*

Et nonn, on formule plutôt des hypothèses *étiologiques*, on cherche la cause des maladies, leurs origines.

✔ **Item B** → *L'épidémiologie analytique permet d'estimer le lien et la force de l'association entre …*

Toutafé !!

✘ **Item C** → *Les programmes d'assainissement rural et d'approvisionnement en eau potable de …*

Le but de ce programme était de fournir des sources d'eau potable pour les populations afin qu'elles évitent de consommer l'eau souillée des rivières, qui était à l'origine d'une forte mortalité infantile. Malheureusement, les puits ont été creusés à des endroits où les eaux étaient contaminées à l'arsenic, mais ce n'était pas le problème à l'origine. Apprenez bien quels organismes sont à l'origine de quelle action. Il y a plein de pièges possibles.

✘ **Item D** → *L'étude de Framingham a été conduite sur une seule génération*

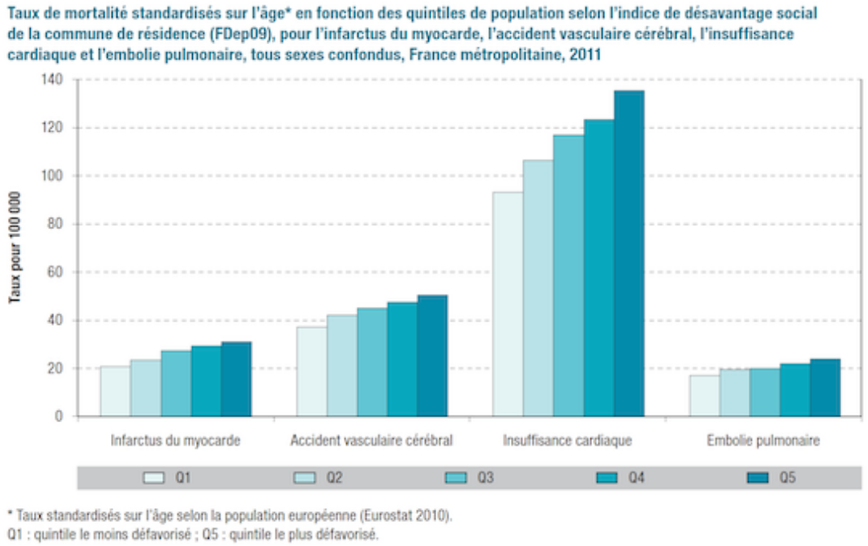
Faux !!! Elle s'est déroulée sur **plusieurs** générations, c'est une des raisons pour lesquelles elle est si populaire.

✘ **Item E** → *L'épidémiologie évaluative permet d'évaluer l'efficacité d'interventions …*

Nonnn, on n'évalue pas seulement les interventions thérapeutiques mais aussi les interventions de santé publique, les politiques de santé, etc… Faites attention aux pièges péremptoires !

Réponse vraie : B

Question 4
En vous appuyant sur vos connaissances et ce graphique portant sur les maladies cardio-vasculaires, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. Le taux de mortalité lié aux accidents vasculaires cérébraux est plus élevé que celui lié à l'infarctus du myocarde
B. On peut comparer ces taux avec ceux d'autres pays
C. L'indice de désavantage social n'est pas un facteur aggravant de ces pathologies
D. Ce document relève de l'épidémiologie analytique, car ces pathologies sont étudiées dans la cohorte de Framingham
E. Le diabète est un facteur de risque des pathologies présentées

Question 4

✔ **Item A** → *Le taux de mortalité lié aux accidents vasculaires cérébraux est plus élevé que celui ...*

Tout à fait ! On remarque que le taux de mortalité par AVC est en moyenne de **40 pour 100 000 contre 25 pour 100 000** avec l'infarctus du myocarde.

✔ **Item B** → *On peut comparer ces taux avec ceux d'autres pays*

Exactement ! Dans la légende, il est indiqué que les **taux sont standardisés sur l'âge** : cela élimine des facteurs de confusion comme l'âge, permettant ainsi les comparaisons entre différentes populations.

✘ **Item C** → *L'indice de désavantage social n'est pas un facteur aggravant de ces pathologies*

Au contraire ! On remarque que plus la **population est défavorisée socialement** (plus le quintile de population est élevé), plus le **taux de mortalité lié à ces pathologies augmente**. Le désavantage social est donc un facteur aggravant de ces maladies.

✘ **Item D** → *Ce document relève de l'épidémiologie analytique, car ces pathologies sont étudiées ...*

Attention : les maladies cardiovasculaires ont certes été étudiées dans la cohorte de Framingham, mais ce document ne relève pas de l'épidémiologie analytique.

— Dans l'épidémiologie analytique, on détermine les facteurs de risque tout en faisant des calculs afin de déterminer la force de l'association entre le facteur et la maladie.

— Dans l'épidémiologie descriptive, on regarde la fréquence des pathologies selon plusieurs facteurs, comme le sexe, l'âge ou la catégorie sociale.

À travers ce document, on regarde la **fréquence de ces maladies** mais on n'étudie pas la force de l'association, donc le document relève de l'**épidémiologie descriptive** et non analytique.

✔ **Item E** → *Le diabète est un facteur de risque des pathologies présentées*

Exactement ! Le diabète est un **facteur de risque des maladies cardiovasculaires**.

Réponses vraies : A, B et E

Question 5
D'après vos connaissances et par lecture du tableau, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

Taux d'incidence et de mortalité en France selon l'année et par âge – Tous cancers hors prostate et sein

	Âge (années)	Homme			Femme		
		1990	2018	VAM* (%)	1990	2018	VAM* (%)
INCIDENCE							
	40	139,1	125,3	-0,4 [-0,7 ; 0,0]	100,2	145,5	1,3 [1,0 ; 1,6]
	50	461,0	329,9	-1,2 [-1,4 ; -1,0]	220,7	306,5	1,2 [0,9 ; 1,4]
	60	1 040,6	962,9	-0,3 [-0,4 ; -0,1]	401,4	549,2	1,1 [0,9 ; 1,3]
	70	1 625,2	1 624,5	0,0 [-0,2 ; 0,1]	648,8	880,6	1,1 [0,9 ; 1,3]
	80	1 842,6	2 219,0	0,7 [0,5 ; 0,8]	856,4	1 154,3	1,1 [0,9 ; 1,2]
MORTALITÉ							
	40	64,6	22,6	-3,7 [-3,9 ; -3,5]	29,8	18,1	-1,8 [-2,0 ; -1,6]
	50	261,4	110,2	-3,0 [-3,1 ; -3,0]	84,3	75,5	-0,4 [-0,5 ; -0,3]
	60	697,9	436,0	-1,7 [-1,7 ; -1,6]	204,4	196,5	-0,1 [-0,2 ; -0,1]
	70	1 173,1	761,2	-1,5 [-1,6 ; -1,5]	421,6	341,5	-0,8 [-0,8 ; -0,7]
	80	1 898,0	1 333,9	-1,3 [-1,3 ; -1,2]	850,7	656,8	-0,9 [-1,0 ; -0,9]

* : Variation Annuelle Moyenne

Incidence : taux d'incidence pour 100000 personnes-années
Mortalité : taux de décès pour 100000 personnes-années

Source : Etude à partir des registres des cancers du réseau Francim, Santé Publique France et Institut National du Cancer

A. Le tableau met en évidence une diminution de la mortalité des cancers avec l'augmentation de l'âge chez les deux sexes
B. On peut conclure que la mortalité diminue d'environ 0,4% chaque année chez chaque femme agée de 50 ans
C. La principale cause de décès en France est le cancer par la présence de tumeurs en 2020
D. Chez les hommes, les cancers sont de moins en moins fréquents avec l'âge car leur incidence diminue entre 1990 et 2018
E. Chez les femmes de 40 ans, l'incidence en 2018 est de 0,1455% par an et la prévalence approximative pour une durée approximative de 730 jours est de 0,291%

Question 5

✘ **Item A** → *Le tableau met en évidence une diminution de la mortalité des cancers avec …*

Alors là il fallait bien comprendre *"une diminution de la mortalité des cancers avec l'augmentation de l'âge"*. Il faut bien distinguer l'évolution avec l'âge et l'évolution dans le temps. En 2018, la mortalité augmente avec l'âge chez les deux sexes.
Hommes en 2018 :
- 40 ans : **22,6 pour 100000 personnes-années**
- 80 ans : **1 333,9 pour 100000 personnes-années**

Femmes en 2018 :
- 40 ans : **18,1 pour 100000 personnes-années**
- 80 ans : **656,8 pour 100000 personnes-années**

Le tableau met en évidence **une AUGMENTATION de la mortalité avec l'âge chez les deux sexes, MAIS une DIMINUTION de la mortalité entre 1990 et 2018**, donc l'item est faux.

✘ **Item B** → *On peut conclure que la mortalité diminue d'environ 0,4% chaque année chez chaque …*

On y était presque ! On peut bien conclure à une diminution **moyenne** annuelle de la mortalité de 0,4% sur la période étudiée. Mais le piège est : *« chez chaque femme »*.
La VAM est un indicateur **POPULATIONNEL**. Elle ne signifie pas que la mortalité diminue de 0,4% chaque année chez CHAQUE individu.
Vous vous dites c'est quoi ces pièges ? Les profs ne sont pas vicieux à ce point mais c'est pour vous montrer la rigueur des termes employés pour chaque expression ou outils calculatoire comme avec la prévalence ou l'incidence pour lesquelles on va retrouver des indications comme "à une période donnée, dans un lieu donné".

✔ **Item C** → *La principale cause de décès en France est le cancer par la présence de tumeurs en 2020*

Ouiii ! Retenez bien la diapo :

Principales causes de décès en France en 2020

- Tumeurs (247,5)
- Maladies cardio-neurovasculaires (175,1)
- Covid-19 (92,9)
- Causes externes de morbidité et mortalité (accident de la route, suicides, noyades chutes accidentelles) (56,2)
- Maladies de l'appareil respiratoire (52,7)
- Maladie du système nerveux et des organes des sens (47,8)

Diapo 46 - Cours 1 - Dr. Astrid Chevancei

✘ **Item D** → *Chez les hommes, les cancers sont de moins en moins fréquents avec l'âge car leur …*

Attention ! Les cancers sont de plus en plus fréquents avec l'âge (l'incidence augmente avec la tranche d'âge : de 125,3 à 40 ans à 2 219,0 à 80 ans en 2018). La **baisse de l'incidence** observée entre 1990 et 2018 sur certaines tranches d'âge mesure l'**évolution temporelle et non l'effet de l'âge**.

✔ **Item E** → *Chez les femmes de 40 ans, l'incidence en 2018 est de 0,1455% par an et la prévalence …*

Oui ! Avec ces magnifiques calculs :

$$\textbf{Taux d'incidence en 2018} = \frac{145,5}{100000} = 0,001455 = \textbf{0,1455\% par an}$$

En appliquant l'approximation classique $\textit{Prévalence} \approx \textit{Incidence} \times \textit{durée}$ (valable pour une incidence faible et stable), sur 2 ans (730 jours) : $0,1455\% \times 2 = \mathbf{0,291\%}$. Le calcul est cohérent.
Bon, cette question était assez complexe avec des items plus longs que jamais, mais c'est pour vous préparer à ne pas rester trop longtemps sur une question. Bon courage pour la suite de la correction !

Réponses vraies : C et E

Question 6
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Dans une population, si durant le temps de l'étude, certaines personnes sont atteintes deux fois par la même infection alors cela impacte le taux d'incidence
B. Dans une population, si durant le temps de l'étude, certaines personnes sont atteintes deux fois par la même maladie alors cela impacte la prévalence de l'infection
C. Dans une population, le fait que certaines personnes aient deux fois la maladie étudiée ne change en rien le taux d'incidence
D. Dans une population, le fait que certaines personnes aient deux fois la même maladie étudiée ne change en rien la prévalence
E. Si la prévalence d'une maladie est faible alors l'incidence est égale à la durée de la maladie multipliée par cette prévalence

Question 6

✘ **Item A** → *Dans une population, si durant le temps de l'étude, certaines personnes sont ...*

Quand on parle du taux d'incidence, c'est en fonction du nombre de malades, pas le nombre d'infections. Une personne atteinte deux fois ne compte qu'une fois.

✘ **Item B** → *Dans une population, si durant le temps de l'étude, certaines personnes sont ...*

Même principe, on compte dans la prévalence le nombre de personnes atteintes, pas le nombre de fois où elles sont malades.

✔ **Item C** → *Dans une population, le fait que certaines personnes aient deux fois la maladie ...*

Toutafé !! Cf. item A

✔ **Item D** → *Dans une population, le fait que certaines personnes aient deux fois la même maladie ...*

Yep c'est ça. Cf. item B

✘ **Item E** → *Si la prévalence d'une maladie est faible alors l'incidence est égale à la durée de la ...*

Attention aux inversions !! Ici il faut remplacer « prévalence » par « incidence ». Je vous remets la formule : **Prévalence** $\approx$ **Incidence** $\times$ **durée** .

Réponses vraies : C et D

Question 7
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La multimorbidité est définie par la présence d'au moins une pathologie chronique
B. Les mesures négatives de la santé sont plus opérationnelles que les mesures positives
C. Les indicateurs de qualité de vie sont des indicateurs multidimensionnels et subjectifs
D. Les indicateurs fonctionnels abordent la santé en termes de conséquences des maladies
E. Le choix d'un indicateur de santé, plutôt qu'un autre est un choix politique qui doit être fait à la lumière de priorités de santé prédéfinies

Question 7

✘ **Item A** → *La multimorbidité est définie par la présence d'au moins une pathologie chronique*

Et non !! On parle de multimorbidité lorsqu'il y a la présence d'au moins **deux** pathologies chroniques.

✔ **Item B** → *Les mesures négatives de la santé sont plus opérationnelles que les mesures positives*

C'est vrai qu'on mesure plus souvent la maladie ou ses conséquences car c'est plus simple et objectif à mesurer que la santé en elle-même. Les mesures positives sont considérées comme moins opérationnelles.

✔ **Item C** → *Les indicateurs de qualité de vie sont des indicateurs multidimensionnels et subjectifs*

C'est exactement ça.

✔ **Item D** → *Les indicateurs fonctionnels abordent la santé en termes de conséquences des maladies*

Encore vrai !! Plus précisément des conséquences des maladies, des accidents ou du vieillissement sur le fonctionnement de l'individu.

✔ **Item E** → *Le choix d'un indicateur de santé, plutôt qu'un autre est un choix politique qui doit ...*

On termine avec un item vrai. Il faut se dire qu'il n'existe pas d'indicateur universel et que selon les indicateurs que l'on choisit, les résultats peuvent être différents.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 8
Concernant les grands problèmes de santé en France, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La santé de la population desservie est un état de santé moyen prenant en compte les différences entre les personnes ayant un très bon état de santé et les personnes ayant un mauvais état de santé

B. La conception positive de la santé désigne le fait que les professionnels de santé doivent adopter un comportement optimiste face aux patients

C. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain

D. L'objectif de la bonne santé, dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population desservie, est double : la qualité (la plus faible différence possible entre individus et entre groupes) et l'équité (le meilleur niveau moyen réalisable)

E. Réduire les décès évitables, les incapacités évitables et les inégalités face à la santé font partie des objectifs d'une politique de santé

Question 8

✘ **Item A** → *La santé de la population desservie est un état de santé moyen prenant en compte…*

Alors alors une petite définition sur la santé de la population desservie : il s'agit d'un **état de santé moyen** prenant en compte les différences entre les plus **riches** et les plus **pauvres** et luttant contre les **inégalités sociales de santé**, et réduisant leurs écarts.

✘ **Item B** → *La conception positive de la santé désigne le fait que les professionnels de santé…*

Attention ! Voilà la définition de la conception positive de la santé : la santé est une **ressource de la vie quotidienne** et non le but de la vie ; cette conception met en valeur les **ressources sociales et individuelles**, ainsi que les **capacités physiques**.

✔ **Item C** → *La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un…*

Oui c'est ça !

✘ **Item D** → *L'objectif de la bonne santé, dans le cadre de l'amélioration de la santé de la…*

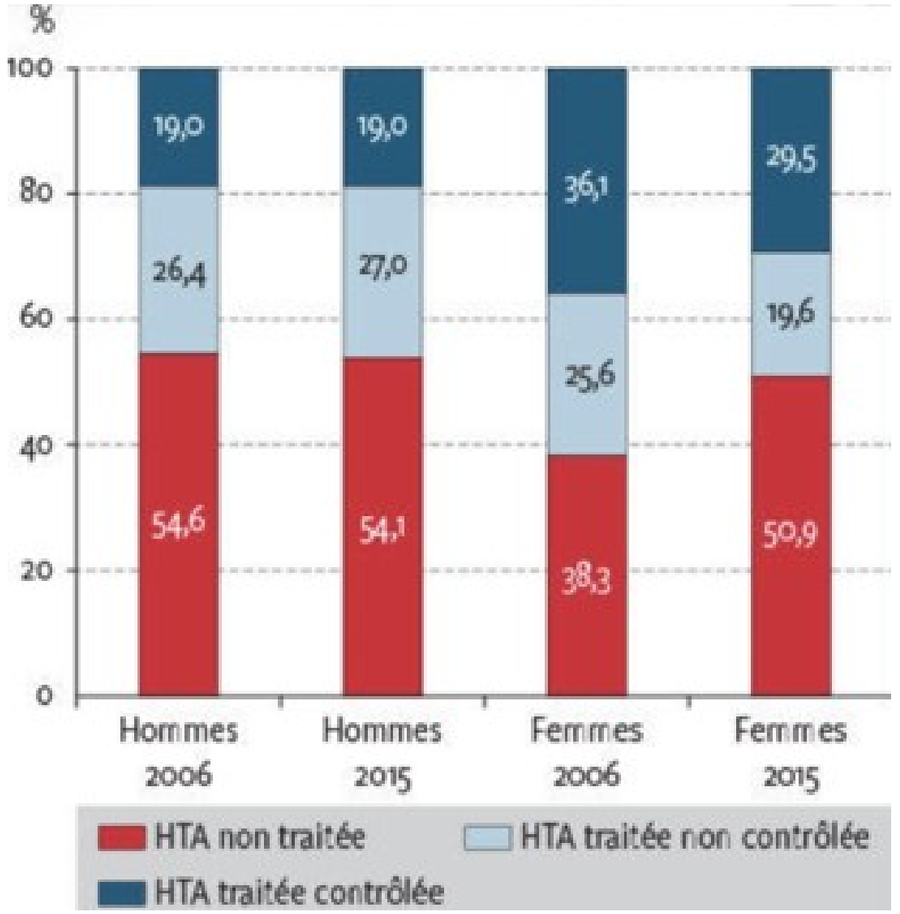
Presque, il faut juste inverser le contenu des parenthèses et on sera bon ! Dans les items bien longs comme ça, on lit avec attention et on valide avec prudence !

✔ **Item E** → *Réduire les décès évitables, les incapacités évitables et les inégalités face à la santé…*

Oui c'est exactement ça ! Ce sont bien des objectifs d'une politique de santé.

Réponses vraies : C et E

Question 9
D'après vos connaissances et par lecture du graphique, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. En 2006, parmi les hommes ayant une HTA, 54,6% des hommes ont une HTA non traitée

B. Que ce soit en 2006 ou en 2015, chez les hommes comme chez les femmes, la majorité des patients ayant une HTA ne sont pas traités

C. Le pourcentage des femmes ayant une HTA traitée contrôlée en 2015 a diminué comparé à celui de 2006

D. Le pourcentage des hommes ayant une HTA traitée contrôlée est le même en 2006 et 2015, soit 19%

E. L'HTA est un facteur de risque des maladies cardio-vasculaires

Question 9

✔ **Item A** → *En 2006, parmi les hommes ayant une HTA, 54,6% des hommes ont une HTA non…*

YESSS c'est ça, déjà la légende nous indique que la partie en rouge correspond à l'HTA non traitée, puis on regarde la 1ère colonne. P'tit conseil : avant de lire les items, LISEZ BIEN **LE TITRE ET LA LÉGENDE**.

✘ **Item B** → *Que ce soit en 2006 ou en 2015, chez les hommes comme chez les femmes, la majorité …*

AIEEEE presque, pour répondre à cette proposition, il fallait comparer le pourcentage d'HTA non traitée contre le pourcentage d'HTA traitée contrôlée et traitée non contrôlée. Dans la 3ème colonne, nous pouvons voir qu'il y a **38,3%** des femmes ayant une HTA non traitée contre **61,7%** des femmes ayant une HTA soit traitée contrôlée, soit traitée non contrôlée. Ce qui rend l'item faux.

✔ **Item C** → *Le pourcentage des femmes ayant une HTA traitée contrôlée en 2015 a diminué …*

OUIII, on peut voir qu'en 2006 (3ème colonne), **36,1%** des femmes avaient une HTA traitée contrôlée contre **29,5%** des femmes en 2015 (4ème colonne).

✔ **Item D** → *Le pourcentage des hommes ayant une HTA traitée contrôlée est le même en 2006 …*

Tout est bon, on regarde les 2 premières colonnes et la partie en bleu foncé qui correspond bien au pourcentage d'HTA traitée contrôlée.

✔ **Item E** → *L'HTA est un facteur de risque des maladies cardio-vasculaires*

Oui ! L'HTA est un facteur de risque des maladies cardio-vasculaires !

Réponses vraies : A, C, D et E

Question 10
Concernant les grands problèmes de santé en France, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Un des grands objectifs d'une politique de santé est de répondre aux attentes des gens

B. Le rapport de la DREES datant de 2022 souligne l'importance des troubles anxieux et dépressifs dans la population

C. La démarche de santé publique est faite de 5 étapes et se termine par la mise en place d'actions de santé

D. La période hygiéniste précède la période biomédicale et permet la baisse de la mortalité infectieuse grâce à l'amélioration de la qualité de l'environnement

E. L'évolution de l'incidence du cancer entre 1990 et 2023 est principalement liée à une augmentation de risque de cancer

Question 10

✔ **Item A** → *Un des grands objectifs d'une politique de santé est de répondre aux attentes des gens*

OUIII on commence cette question par un item juste ! Une politique de santé publique cherche également à **améliorer la santé de la population desservie** et à **assurer une protection financière contre les coûts associés à une mauvaise santé** !

✘ **Item B** → *Le rapport de la DREES datant de 2022 souligne l'importance des troubles anxieux …*

Non… Désolée c'était vilain de ma part mais ce n'est pas les troubles anxieux, bien les troubles du sommeil.

✘ **Item C** → *La démarche de santé publique est faite de 5 étapes et se termine par la mise en …*

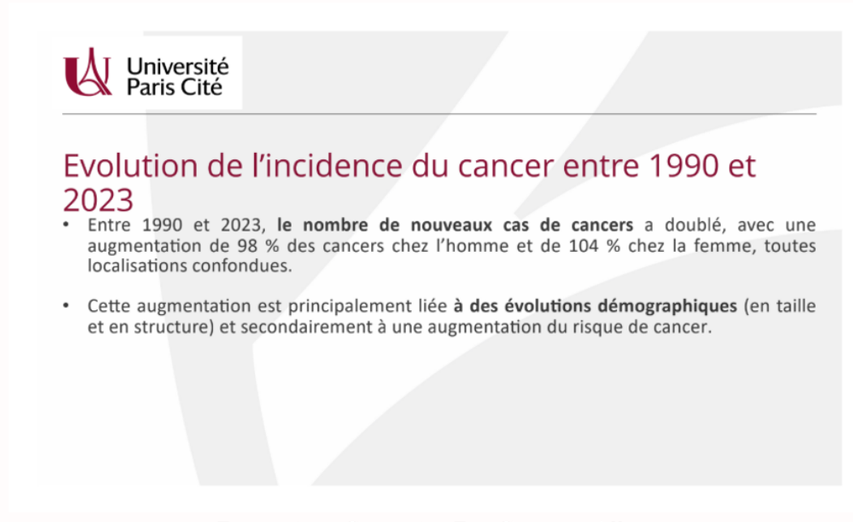
Aïe, tout est faux dans l'item. Déjà il n'y a que 4 étapes dans la démarche de santé publique que l'on peut retrouver grâce à l'acronyme **ADME** : Analyser le problème, Définir les priorités de santé, Mettre en place des actions de santé, **Évaluer les actions mises en place**. En santé publique on cherche toujours à mesurer l'efficacité de nos actions afin de pouvoir les maintenir ou bien les modifier. Petit tips : si vous aviez déjà cramé que l'item était faux avec les 5 étapes on ne coche pas et on passe direct à la suite, ça suffit pour disqualifier l'item !!!

✔ **Item D** → *La période hygiéniste précède la période biomédicale et permet la baisse de la …*

Exactement ! Petit rappel (je vous jure qu'on m'a posé plusieurs fois la question) : précède c'est avant, on **pré**pare quelque chose à l'avance donc c'est avant chronologiquement ; et succède c'est après !!!

✘ **Item E** → *L'évolution de l'incidence du cancer entre 1990 et 2023 est principalement liée à une …*

Nope désolée c'était un peu vicieux de ma part (cœur sur vous ❤️), mais cette évolution, qui est une augmentation comme on se doutait, est d'abord liée à des évolutions démographiques. Je vous remets la diapo, faites bien gaffe à ce que la prof met en gras.



Diapo 31 - Cours 2 - Pr. Corinne Alberti

Réponses vraies : A et D

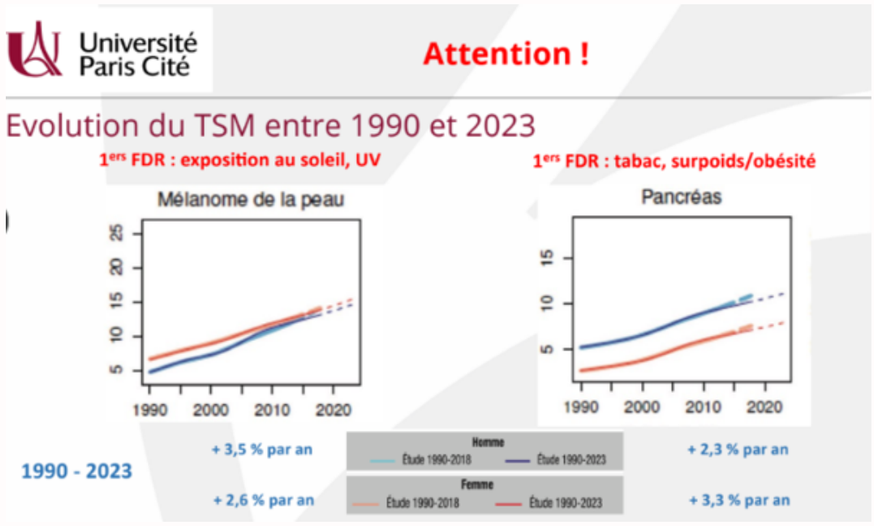
Question 11
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le taux de mortalité lié au cancer du pancréas a tendance à diminuer en France
B. L'incidence et la prévalence du cancer du poumon chez la femme diminuent en France
C. L'apparition du cancer de la prostate est liée à des facteurs de risque génétiques
D. Le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers ayant un mauvais pronostic
E. Le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers ayant un bon pronostic

Question 11

✘ **Item A** → *Le taux de mortalité lié au cancer du pancréas a tendance à diminuer en France*

Et non ! Il a tendance à **augmenter** comme on peut le voir sur cette diapo :



Diapo 43 - Cours 2 - Pr. Corinne Alberti

✘ **Item B** → *L'incidence et la prévalence du cancer du poumon chez la femme diminuent en France*

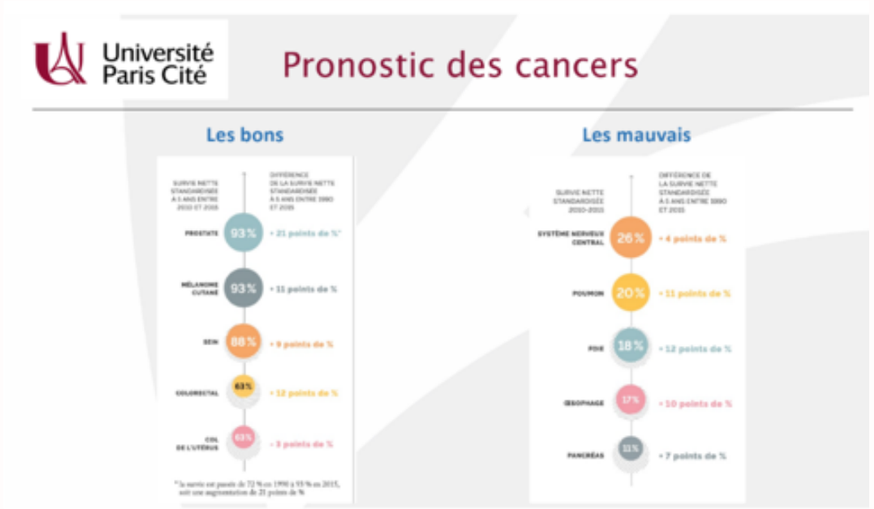
Alors non attention !! Chez les femmes, l'**incidence** des cancers (dont celui du poumon) AUGMENTE. En revanche, si on parlait des hommes cet item aurait été vrai.
Petit rappel : l'incidence correspond au *nombre de nouveaux cas apparus sur une période donnée.*

✔ **Item C** → *L'apparition du cancer de la prostate est liée à des facteurs de risque génétiques*

C'est exact ! C'est d'ailleurs le 1er FDR de ce cancer.

? **Item D et E**

Le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers ayant un **bon** pronostic. Je vous remets la diapo courage !!



Diapo 44 - Cours 2 - Pr. Corinne Alberti

Réponses vraies : C et E

Question 12
Concernant les grands problèmes de santé en France, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Chez les hommes les 3 principales localisations de cancer sont la prostate, le poumon et le pancréas
B. Les plans Cancer sont des plans nationaux à stratégie quinquennale
C. 30% des cancers pourraient être prévenus par la modification de nos comportements
D. Les troubles mentaux représentent le premier poste de dépenses du régime général de l'assurance maladie
E. 33% des adultes ont connaissance de leur hypercholestérolémie

Question 12

❌ **Item A** → *Chez les hommes les 3 principales localisations de cancer sont la prostate, le poumon …*

Oups un intrus s'est glissé dans la liste, la 3e place est réellement occupée par le cancer colorectal ! Je vous mets la diapo, petit conseil d'ami apprenez bien les différences entre les hommes et les femmes, la différence dans l'ordre entre les types de cancer selon la mortalité ou la localisation (je sais vous êtes en train de souffler du nez, croyez moi j'fais pareil en rédigeant mais ça peut tomber 🥲).

- Chez les femmes, les 3 principales localisations de cancer sont le sein, le colon, le poumon et les 3 principales causes de mortalité par cancer sont le sein, le poumon, le colon. L'incidence et la mortalité par cancer du poumon augmentent.
- Chez les hommes, les 3 principales localisations de cancer sont la prostate, le poumon, le colon et les 3 principales causes de mortalité par cancer sont le poumon, le colon, la prostate.

Diapo 45 - Cours 2 - Pr. Corinne Alberti

❌ **Item B** → *Les plans Cancer sont des plans nationaux à stratégie quinquennale*

Nope, ça partait bien pourtant les plans Cancer sont bien des plans nationaux mais ils sont à stratégie décennale.

❌ **Item C** → *30% des cancers pourraient être prévenus par la modification de nos comportements*

Et bah c'est encore faux et c'est encore du par ❤️ pour changer… C'était **40%** la bonne réponse (ouais c'est giga beaucoup je suis d'accord, prenez soin de vous, vos poumons et votre foie svp).

✔️ **Item D** → *Les troubles mentaux représentent le premier poste de dépenses du régime général …*

YAYYY un item vrai !! C'est tout à fait ça, c'est bien le premier poste devant les cancers et les maladies cardio-vasculaires.

❌ **Item E** → *33% des adultes ont connaissance de leur hypercholestérolémie*

Là vous vous dites certainement que je vous casse les pieds (pour être polie) avec mes questions et qu'en plus j'ai le culot de transcrire les fréquences en pourcentage (j'ose je suis désolée). Toujours est-il que c'est pas ça la bonne réponse, on est plutôt sur un adulte sur deux qui est au courant de son hypercholestérolémie.

Réponse vraie : D

Question 13
Concernant les grands problèmes de santé en France, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans les actions de santé publique, on peut retrouver les plans nationaux, les dépistages organisés et les investissements dans la recherche en prévention secondaire

B. Les tumeurs sont la cause de mortalité la plus fréquente en France

C. La mortalité évitable représente 1/3 des décès

D. Les problèmes oculaires font partie des principales causes de mortalité ressentie en population générale

E. Les maladies chroniques concernent plus de 20 millions de personnes en France

Question 13

❌ **Item A** → *Dans les actions de santé publique, on peut retrouver les plans nationaux, les …*

Désolée ça commence mal… On retrouve les plans nationaux, les dépistages organisés, et les investissements dans la recherche en prévention **primaire**.

✔️ **Item B** → *Les tumeurs sont la cause de mortalité la plus fréquente en France*

Ouiii c'est tout bon.

❌ **Item C** → *La mortalité évitable représente 1/3 des décès*

Erreur tout à fait compréhensible, attention à ne pas confondre la mortalité évitable et la mortalité prématurée 😉. La mortalité prématurée représente 20% des décès et la mortalité évitable représente **1/3 de la mortalité prématurée**.

❌ **Item D** → *Les problèmes oculaires font partie des principales causes de mortalité ressentie en …*

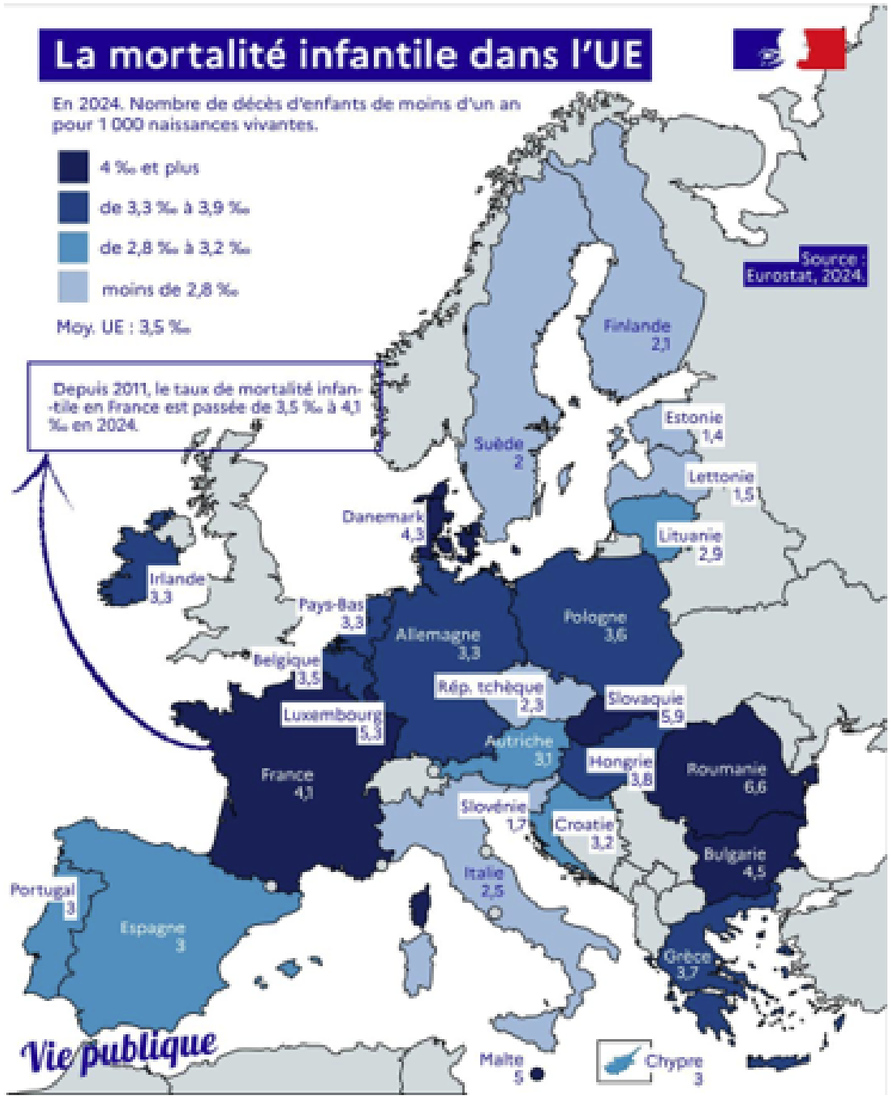
Nonnnn sorry pour le piège… Il ne faut pas lire trop vite, surtout en SP ! Les maladies oculaires font partie des principales causes de **morbidité** ressentie.

✔️ **Item E** → *Les maladies chroniques concernent plus de 20 millions de personnes en France*

Ouii c'est absolument ça !

Réponses vraies : B et E

Question 14
D'après vos connaissances et par lecture du graphique, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. Le taux de mortalité infantile en France a augmenté de 0,6% entre 2011 et 2024
B. Malte est le troisième pays de l'UE avec le taux de mortalité infantile le plus important

C. Plus d'1 pays sur 3 de l'UE ont un taux de mortalité supérieur à la moyenne de l'UE
D. La hausse du nombre de naissances multiples est l'un des divers risques identifiés pour expliquer la hausse de la mortalité infantile
E. En 2024, la Slovaquie enregistre 20 000 naissances vivantes et 118 décès d'enfants de moins d'un an

Question 14

✘ **Item A** → *Le taux de mortalité infantile en France a augmenté de 0,6% entre 2011 et 2024*

Le taux est passé de 3,5% à 4,1%. L'augmentation absolue est de 0,6 point de par mille ou points de pour mille, et non 0,6%.

✘ **Item B** → *Malte est le troisième pays de l'UE avec le taux de mortalité infantile le plus important*

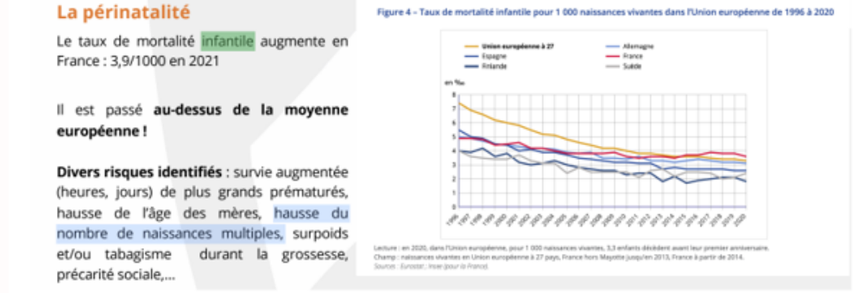
Petite confusion ! Malte figure parmi les pays ayant les taux les plus élevés de l'UE , se classant en 4ème position derrière la Roumanie, la Slovaquie et le Luxembourg.

✔ **Item C** → *Plus d'1 pays sur 3 de l'UE ont un taux de mortalité supérieur à la moyenne de l'UE*

Vrai. 10 pays sur les membres représentés ont un taux supérieur à la moyenne européenne (3,5%), soit environ 38,5% des pays (plus d'un tiers).

✔ **Item D** → *La hausse du nombre de naissances multiples est l'un des divers risques identifiés ...*

Oui totalement, par "hausse du nombre de naissances multiples" on désigne une augmentation du nombre d'accouchements donnant naissance à plus d'un enfant à la fois.
Ce facteur fait bien partie des risques expliquant la hausse de la mortalité infantile, pour preuve voilà la diapo de la prof :



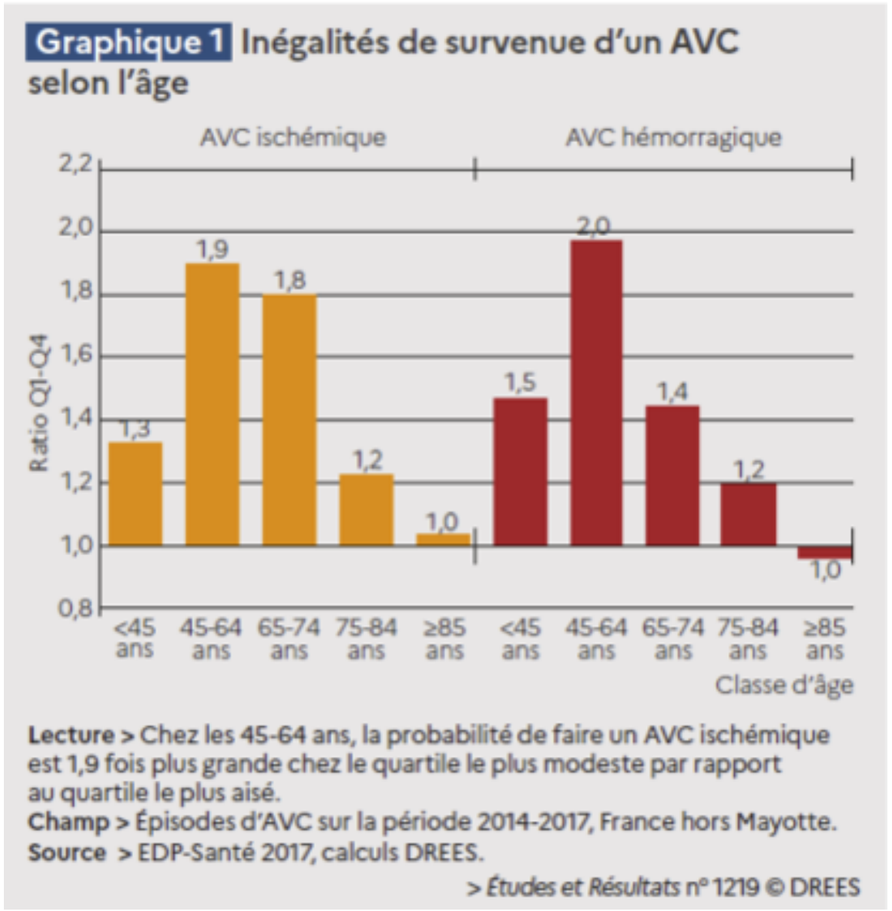
Diapo 95 - Cours 2 - Pr. Corinne Alberti

✔ **Item E** → *En 2024, la Slovaquie enregistre 20 000 naissances vivantes et 118 décès d'enfants ...*

Le calcul du taux : $\frac{118}{20\,000} \times 1\,000 = \frac{118}{20} = 5{,}9$ ‰. Identification : La Slovaquie affiche un taux de 5,9 ‰ sur la carte.

Réponses vraies : C, D et E

Question 15
D'après vos connaissances et par lecture du graphique, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. L'AVC ischémique présente un ratio d'inégalité plus élevé que l'AVC hémorragique dans la tranche d'âge des 65-74 ans
B. L'AVC hémorragique présente un ratio d'inégalité plus élevé que l'AVC ischémique dans la tranche d'âge des <45 ans
C. Le ratio maximal d'inégalité observé sur le graphique concerne l'AVC ischémique
D. Pour les deux types d'AVC, le ratio retombe à 1,0 chez les 85 ans et plus
E. Près de 4 AVC sur 5 sont dus à une rupture d'un vaisseau sanguin cérébral

Question 15

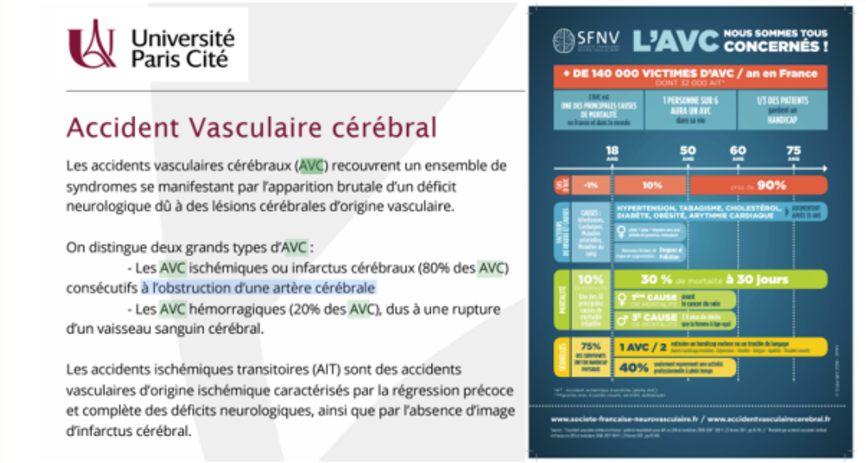
✔ **Item A** → *L'AVC ischémique présente un ratio d'inégalité plus élevé que l'AVC hémorragique ...*
Oui, **1,8 (ischémique) > 1,4 (hémorragique)** pour les 65-74 ans.

✔ **Item B** → *L'AVC hémorragique présente un ratio d'inégalité plus élevé que l'AVC ischémique ...*
Exact, **1,5 (hémorragique) > 1,3 (ischémique)** pour les <45 ans.

✘ **Item C** → *Le ratio maximal d'inégalité observé sur le graphique concerne l'AVC ischémique*
Non, le ratio maximal est 2,0, il concerne l'AVC **hémorragique** (chez les 45-64 ans).

✔ **Item D** → *Pour les deux types d'AVC, le ratio retombe à 1,0 chez les 85 ans et plus*
Ouiii, à >85ans, les deux types d'AVC atteignent un ratio d'inégalité de 1,0.

✘ **Item E** → *Près de 4 AVC sur 5 sont dus à une rupture d'un vaisseau sanguin cérébral*
C'est un item qui a du vice +++. Près de 4 AVC sur 5 sont dus à **l'obstruction d'une artère cérébrale**. Ici il faut faire attention au fait que 4 sur 5 équivaut à 80%. Voilà la diapo du cours qui fait référence :



Diapo 69 - Cours 2 - Pr. Corinne Alberti

Réponses vraies : A, B et D

Question 16
Concernant les inégalités sociales de santé, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Les inégalités sociales de santé (ISS) sont définies comme des différences systématiques, inévitables et importantes dans le domaine de la santé observées entre des groupes sociaux
B. Les inégalités sociales de santé (ISS) ne concernent qu'une partie de la population, à savoir les personnes les plus défavorisées
C. Chaque classe sociale présente un niveau de mortalité et de morbidité plus bas que celui de la classe immédiatement inférieure
D. L'étude des ISS est valable pour l'étude d'éléments négatifs pour la santé (ex : mortalité) mais également d'éléments positifs pour la santé (ex : espérance de vie)
E. Les inégalités sociales de santé sont réparties selon un gradient social

Question 16

✘ **Item A** → *Les inégalités sociales de santé (ISS) sont définies comme des différences…*

Aïe aïe aïe… Ici on a une très longue définition mais il faut tout lire et aller jusqu'au bout ! Les ISS sont définies comme des différences systématiques, **ÉVITABLES** et non pas inévitables. Le reste de la proposition est bon !

✘ **Item B** → *Les inégalités sociales de santé (ISS) ne concernent qu'une partie de la population, …*

Nooooon ! Au contraire, les inégalités sociales de santé concernent **TOUTE la population**. En effet, on s'intéresse autant aux classes sociales défavorisées qu'à celles qui sont aisées.

✔ **Item C** → *Chaque classe sociale présente un niveau de mortalité et de morbidité plus bas que…*

Ouiiii c'est exactement ça ! Ici on parle de gradient social où l'on fait une association dose-réponse entre la classe sociale et la santé. Plus le gradient social est élevé, plus la personne à de chance d'être en bonne santé comparée à une personne avec un gradient social plus faible.

✔ **Item D** → *L'étude des ISS est valable pour l'étude d'éléments négatifs pour la santé (ex :…*

Ouiii ! C'est exactement ça !

✔ **Item E** → *Les inégalités sociales de santé sont réparties selon un gradient social*

Oui ! C'est souvent ainsi qu'on fait la répartition pour évaluer les inégalités sociales ! On prend souvent les catégories socioprofessionnelles qui vont des ouvriers jusqu'aux cadres.

Réponses vraies : C, D et E

Question 17
Concernant la notion de pauvreté, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?

A. La pauvreté se définit comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux
B. La pauvreté est un concept essentiellement économique
C. La pauvreté monétaire définit un seuil de pauvreté monétaire fixé le plus souvent à 80% du revenu médian français
D. La pauvreté absolue ne dépend pas du niveau de vie de la population
E. La pauvreté touche 20 à 25% de la population en France

Question 17

✘ **Item A** → *La pauvreté se définit comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant…*

Noooon ! L'item est long mais ici on a pris la définition de la **précarité**… La précarité et la pauvreté sont deux notions distinctes !

✔ **Item B** → *La pauvreté est un concept essentiellement économique*

C'est exact ! La pauvreté est un concept **essentiellement économique** contrairement à la précarité qui est un concept multifactoriel.

✘ **Item C** → *La pauvreté monétaire définit un seuil de pauvreté monétaire fixé le plus souvent à…*

Presque… Sauf que le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 60% (parfois 50%) du revenu médian français et non pas 80%.

✔ **Item D** → *La pauvreté absolue ne dépend pas du niveau de vie de la population*

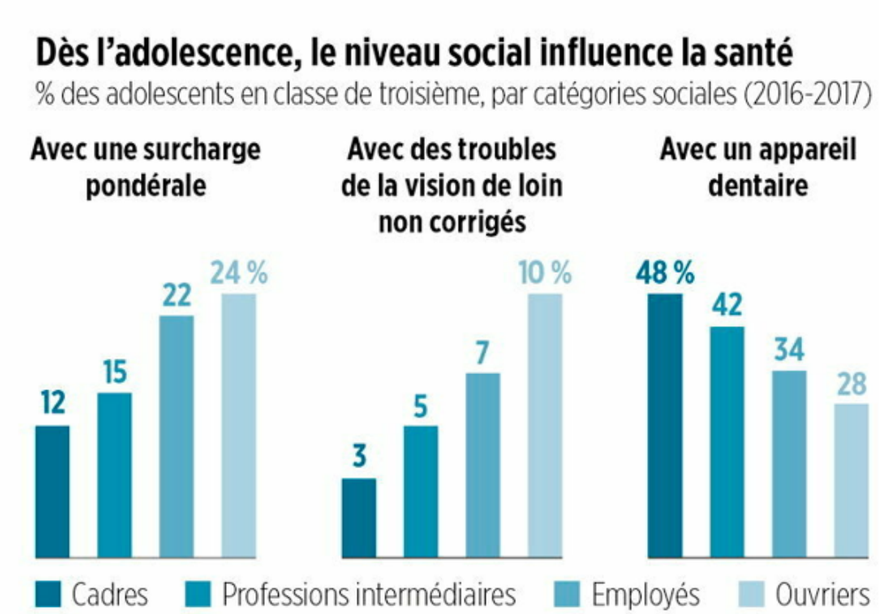
C'est vrai ! La pauvreté absolue définit des biens et services dont la collectivité décide que l'on ne peut priver personne, quoi qu'il arrive (c'est ce qu'on appelle des biens insaisissables). **Elle ne dépend pas du niveau de vie de la population** mais d'éléments indispensables pour vivre.

✘ **Item E** → *La pauvreté touche 20 à 25% de la population en France*

Hop un petit piège pour le dernier item ! Ces pourcentages appartiennent à la notion de précarité et non de pauvreté. Pour rappel, le niveau de pauvreté se mesure de différentes façons donc les **pourcentages varient également selon la méthode employée**. Par exemple, en 2023 : 15,4% de la population est sous le seuil de 60% en terme de pauvreté relative et 40% de la population est sous le seuil de pauvreté en terme de pauvreté absolue.

Réponses vraies : B et D

Question 18
Parmi les propositions suivantes concernant cette figure et vos propres connaissances, indiquez laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s).



A. La santé bucco-dentaire des adolescents diminue lorsque la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents s'élève

B. La part d'adolescents avec une surcharge pondérale est plus importante chez les enfants d'employés que chez ceux dont les parents exercent des professions intermédiaires

C. Chez les adolescents issus d'un milieu ouvrier, 10% présentent des troubles de la vision de loin

D. 48% des adolescents avec un appareil dentaire sont des enfants de cadres

E. Les différences entre catégories sociales dans l'accès à des traitements optiques et dentaires peuvent s'expliquer par une inégalité d'accès à la prévention au cours de la période étudiée

Question 18

✘ **Item A** → *La santé bucco-dentaire des adolescents diminue lorsque la catégorie…*

Non non et non !! Rien dans le document ne fait allusion à la santé bucco-dentaire des adolescents en tant que telle... Le document nous informe simplement de la part des adolescents ayant recours à un traitement orthodontique : **un appareil dentaire**. 🦷
Or, il ne s'agit là que d'une petite partie de l'ensemble des prestations permettant d'agir sur la santé bucco-dentaire ! 😋

✔ **Item B** → *La part d'adolescents avec une surcharge pondérale est plus importante chez les…*

C'est exact ! D'après ce diagramme en bâton, on voit que la part d'adolescents avec une surcharge pondérale s'élève à 22% chez les enfants d'employés, contre 15% chez ceux dont les parents exercent des professions intermédiaires.

✘ **Item C** → *Chez les adolescents issus d'un milieu ouvrier, 10% présentent des troubles de la…*

Méchant piège sorryyy… Ici l'item est incomplet parce que le document évoque la part d'adolescents "avec des troubles de vision de loin non corrigés".
Ainsi, on ne peut pas déterminer la part globale d'adolescents ayant des troubles de la vision, car le graphique ne prend pas en compte ceux dont la vue est déjà corrigée (par des lunettes ou des lentilles).

✘ **Item D** → *48% des adolescents avec un appareil dentaire sont des enfants de cadres*

Aie aie aie… Attention quand vous lisez le graphique à ne pas tout mélanger comme ça. Ici, ce sont 48% des adolescents enfants de cadres qui sont traités avec un appareil dentaire. Beaucoup de nuances dans cette UE c'est vrai, mais avec de l'entraînement vous serez bientôt des pros en lecture de graphique ! 😄

✔ **Item E** → *Les différences entre catégories sociales dans l'accès à des traitements optiques et…*

Tout à fait bravo !

Réponses vraies : B et E

Question 19
Concernant les indicateurs écologiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'une caractérisation synthétique du niveau socioéconomique de la population à une échelle donnée et à un moment donné

B. Un de ses avantages est qu'il prend en compte le contexte du milieu de vie

C. Un de ses avantages est qu'il permet d'agréger plusieurs indicateurs (revenus, chômage, etc.) en un seul

D. Un de ses inconvénients est qu'il est calculé à un temps donné

E. Deux exemples d'indicateurs écologiques sont FDep et EDI (Ecological Deprivation Index)

Question 19

✔ **Item A** → *Il s'agit d'une caractérisation synthétique du niveau socioéconomique de la…*

Oui c'est tout à fait ça !

✘ **Item B** → *Un de ses avantages est qu'il prend en compte le contexte du milieu de vie*

Petit piège ! Au contraire, il **ne** prend **pas** en compte le contexte du milieu de vie, ce qui en fait un inconvénient…

✔ **Item C** → *Un de ses avantages est qu'il permet d'agréger plusieurs indicateurs (revenus, …*

Exact ! C'est écrit mot pour mot dans le cours.

✔ **Item D** → *Un de ses inconvénients est qu'il est calculé à un temps donné*

Oui ! Je remets ici la diapo pour bien faire la différence entre les avantages et les inconvénients !

Université Paris Cité

Indicateurs écologiques

Avantages
- Mesure de la situation socioéconomique des personnes en l'absence de données individuelles
- Permet d'agréger plusieurs indicateurs (revenus, chômage, etc.) en un seul

Inconvénients
- Biais écologique (↓ plus la zone étudiée est petite et homogène)
- Ne prend pas en compte le contexte du milieu de vie
- Calculé à un temps donné, non évolutif
- Traduit autant la richesse d'un territoire que le niveau socio-économique de l'individu qui y habite

Diapo 26 - Cours 3 - Pr. Corinne Alberti, Pr. Isabelle Momas

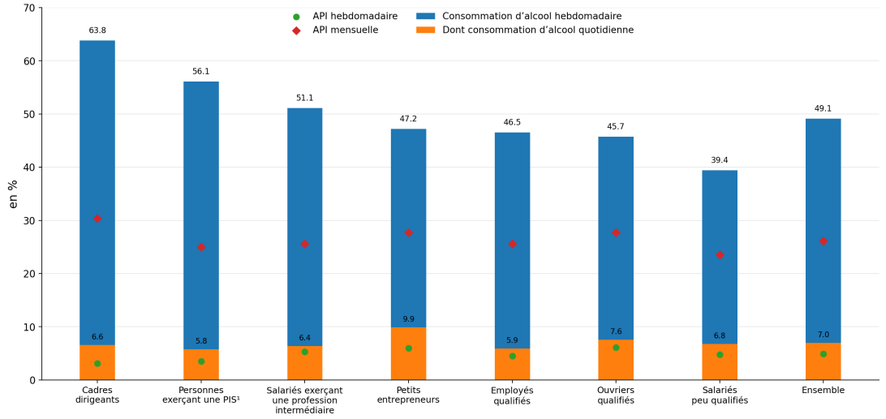
✘ **Item E** → *Deux exemples d'indicateurs écologiques sont FDep et EDI (Ecological Deprivation ...*

C'était presque bon maiiiiis... le concept des parenthèses existe malheureusement. EDI c'est pour **European** deprivation index et non **Ecological** deprivation index.

Réponses vraies : A, C et D

Question 20
Concernant ce graphique et à partir de vos connaissances, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

Figure 3 - Consommation d'alcool selon la catégorie socioéconomique en France en 2019



¹ Profession intellectuelle et scientifique. API = alcoolisation ponctuelle importante (au moins 6 verres standard en une occasion).
Source : Eurostat, EHIS 2019. Champ : France métropolitaine, personnes en emploi âgées de 15 ans ou plus.

A. Les salariés peu qualifiés ont une consommation d'alcool hebdomadaire plus faible que l'ensemble des professions étudiées

B. Les petits entrepreneurs ont une alcoolisation ponctuelle importante mensuelle plus élevée que les cadres dirigeants

C. Environ 50% des salariés exerçant une profession intermédiaire en France métropolitaine comme outre-mer ont une consommation d'alcool hebdomadaire

D. Les facteurs liés aux conditions de vie et de travail sont de niveau 2 dans le modèle des déterminants de la santé

E. L'alcoolisation ponctuelle importante hebdomadaire ne dépasse pas les 10% dans chaque population étudiée

Question 20

✔ **Item A** → *Les salariés peu qualifiés ont une consommation d'alcool hebdomadaire plus faible ...*

Oui c'est ça ! (Environ 50% pour l'ensemble contre **40%** pour les salariés peu qualifiés).

✘ **Item B** → *Les petits entrepreneurs ont une alcoolisation ponctuelle importante mensuelle plus ...*

Non c'est l'inverse ! Je sais que ce n'est pas très lisible mais malheureusement ça arrive souvent en santé publique...

✘ **Item C** → *Environ 50% des salariés exerçant une profession intermédiaire en France ...*

Halte là, petit piège ! Ici notre champ d'étude est la **France métropolitaine sans les outre-mers** ! Ça peut arriver qu'on vous piège sur le champ d'étude alors n'oubliez pas de lire toute la légende 😄.

✘ **Item D** → *Les facteurs liés aux conditions de vie et de travail sont de niveau 2 dans le modèle…*

Presque… ils sont de **niveau 3** ! (Le niveau 2 ce sont les réseaux sociaux et communautaires). Retenez bien le modèle des déterminants de la santé :

Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

- **Niveau 1** : Facteurs liés au style de vie personnel

Comportements et styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations entre amis et dans l'ensemble de la collectivité

- **Niveau 2** : Réseaux sociaux et communautaires

Influences sociales et collectives : les interactions sociales et ces pressions des pairs influencent les comportements individuels de façon favorable ou défavorable

- **Niveau 3** : Facteurs liés aux conditions de vie et de travail

Accès au travail, aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, services de santé, nourriture, l'éducation mais aussi les conditions de travail

- **Niveau 4** : Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales

Facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique du pays et les conditions du marché du travail, le mode de fonctionnement du système de santé, ont une incidence sur toutes les autres strates

Diapo 33 - Cours 3 - Pr. Corinne Alberti

✔ **Item E** → *L'alcoolisation ponctuelle importante hebdomadaire ne dépasse pas les 10% dans…*

Ouiii c'est tout bon ! Vous êtes à plus de la moitié de la correction !!! Bon courage pour la suite !!!

Réponses vraies : A et E

Question 21
Concernant les inégalités sociales de santé et l'accès aux soins, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Il est possible d'observer une baisse d'accès au dépistage avec une baisse du niveau d'éducation/revenus

B. Grâce à différentes aides mises en place, le suivi prénatal nécessaire durant la grossesse est au même niveau chez tout le monde

C. Les cadres présentent le plus de caries et de caries non traitées

D. Plus le niveau d'éducation est bas, plus l'accès à la greffe rénale est réduit

E. Le temps d'accès à la greffe est plus long pour des niveaux d'éducation plus bas

Question 21

✔ **Item A** → *Il est possible d'observer une baisse d'accès au dépistage avec une baisse du niveau…*

Ouii ! C'est exactement ce qu'il y a dans votre cours, l'exemple des femmes ayant effectué une mammographie au cours des deux dernières années selon leur revenu et leur niveau d'étude y est notamment utilisé.

✘ **Item B** → *Grâce à différentes aides mises en place, le suivi prénatal nécessaire durant la…*

Malheureusement j'ai un peu inventé celui-là my bad… Dans vos diapos on vous met bien en avant une différence de suivi en fonction du niveau de précarité (un suivi qui baisse avec une précarité qui augmente).

✘ **Item C** → *Les cadres présentent le plus de caries et de caries non traitées*

Au contraire, les cadres représentent une catégorie professionnelle plutôt élevée, or, vous apprenez que la quantité de caries et caries non traitées augmente avec la catégorie professionnelle qui diminue. Cet item concerne plus les ouvriers ou employés par exemple.

✔ **Item D** → *Plus le niveau d'éducation est bas, plus l'accès à la greffe rénale est réduit*

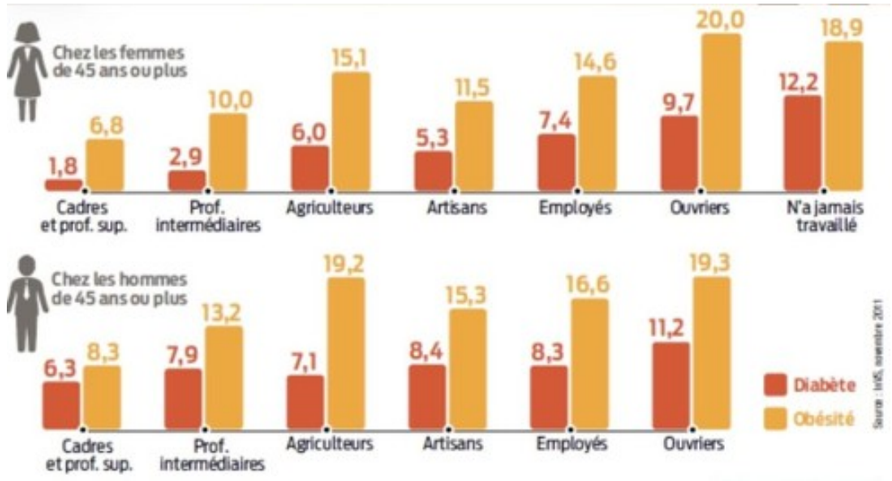
Totalement ! Rien de plus à dire 🦦.

✔ **Item E** → *Le temps d'accès à la greffe est plus long pour des niveaux d'éducation plus bas*

Malheureusement c'est aussi vrai…

Réponses vraies : A, D et E

Question 22
En utilisant vos connaissances et la figure, parmi les propositions suivantes, indiquez laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s).
La figure ci-dessous présente la prévalence en pourcentage du diabète et de l'obésité par catégorie socio-professionnelle et par sexe chez les personnes âgées de 45 ans ou plus.



A. La prévalence des femmes employées souffrant de diabète est plus faible que celle des hommes employés

B. Les hommes souffrent plus d'obésité que les femmes, quelle que soit leur situation socioprofessionnelle
C. Les hommes agriculteurs sont plus sujets au diabète et à l'obésité que les hommes ouvriers
D. La situation professionnelle est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer les ISS
E. Les revenus au sein d'un même groupe socio-professionnel sont homogènes

Question 22

✔ **Item A** → *La prévalence des femmes employées souffrant de diabète est plus faible que celle …*
Et oui, 7,4% des femmes employées souffrent de diabète contre 8,3% chez les hommes.

✘ **Item B** → *Les hommes souffrent plus d'obésité que les femmes, quelle que soit leur situation …*
La prévalence de l'obésité chez les ouvriers est plus forte chez les **femmes** que chez les hommes. Attention à bien regarder la figure en détail 😉 !

✘ **Item C** → *Les hommes agriculteurs sont plus sujets au diabète et à l'obésité que les hommes …*
C'est l'inverse, les prévalences du diabète et de l'obésité sont toutes deux plus fortes chez **les ouvriers** que chez les agriculteurs.

✘ **Item D** → *La situation professionnelle est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer les ISS*
Le critère le plus utilisé est **le niveau d'éducation**.

✘ **Item E** → *Les revenus au sein d'un même groupe socio-professionnel sont homogènes*
Et non, les revenus sont **très variables** au sein d'un même groupe socio-professionnel.

Réponse vraie : A

Question 23
Concernant la précarité et les inégalités sociales de santé, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Quand le revenu diminue, le nombre de fumeurs quotidiens augmente, tandis que les fumeurs occasionnels diminue

B. L'obésité augmente avec le revenu
C. Les personnes n'ayant pas de diplôme ont tendance à être celles se déclarant le plus en bonne santé

D. L'universalisme proportionné représente une intervention avec une intensité proportionnelle aux besoins et aux obstacles auxquels se heurtent certains groupes

E. Cibler seulement les populations défavorisées est la meilleure solution sans risques pour réduire les inégalités

Question 23

✔ **Item A** → *Quand le revenu diminue, le nombre de fumeurs quotidiens augmente, tandis que …*
Attention à ce genre d'item long qui peut cacher plein de pièges ou d'inversions, mais ici pas de panique on est tout bon vous pouvez vous diriger vers le prochain item !

✘ **Item B** → *L'obésité augmente avec le revenu*
Du tout, elle augmente quand le revenu diminue, et inversement, elle diminue quand le revenu augmente 😉.

✘ **Item C** → *Les personnes n'ayant pas de diplôme ont tendance à être celles se déclarant le plus …*
Justement, ce sont celles qui déclarent le plus avoir une limitation d'activité (environ 40,2%), tandis que celles avec un diplôme supérieur considèrent principalement être en assez bonne santé (environ 97,3%).

✔ **Item D** → *L'universalisme proportionné représente une intervention avec une intensité …*
C'est mot pour mot la définition du cours !

✘ **Item E** → *Cibler seulement les populations défavorisées est la meilleure solution sans risques …*
Malheureusement, ce type de ciblage risque d'entraîner plusieurs problèmes. Je vous les redonne :
— risque de stigmatiser un sous groupe
— risque d'assimiler leurs modes de vie aux causes des inégalités de santé
— risque de négliger les besoins des groupes intermédiaires, non inclus dans le ciblage, dont l'état de santé peut être très proche de celui des groupes ciblés

Réponses vraies : A et D

Question 24
Concernant les maladies chroniques, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?

A. La maladie chronique est une situation complexe qui relève de l'interaction de 2 éléments : l'hôte et son environnement

B. Il est nécessaire d'avoir une cause forte dans le cas des maladies chroniques

C. Il est facile de faire de la prévention sur les maladies chroniques

D. La survenue d'un infarctus du myocarde peut résulter de plusieurs facteurs contributifs comme l'hypercholestérolémie, le tabagisme, le diabète et l'hypertension artérielle (HTA)

E. Le stress et l'obésité ne peuvent pas contribuer à la survenue d'une maladie chronique

Question 24

✔ **Item A** → *La maladie chronique est une situation complexe qui relève de l'interaction de 2 …*

C'est exact ! Les maladies chroniques sont des situations où la maladie résulte de **l'interaction de 2 éléments** : l'hôte et son environnement avec la contribution de plusieurs facteurs au développement de la maladie. Il faut les distinguer des maladies infectieuses, parasitaires et carentielles qui, quant à elles, résultent d'une **interaction de 3 éléments** : l'agent causal, l'hôte affecté et l'environnement.

✘ **Item B** → *Il est nécessaire d'avoir une cause forte dans le cas des maladies chroniques*

Nooooon ! Contrairement aux maladies infectieuses, **il n'est pas nécessaire d'avoir une cause forte** ou un agent causal principal identifié. Les maladies chroniques sont qualifiées de situations complexes car une multitude de facteurs étiologiques sont imbriqués les uns dans les autres et amènent à la survenue de la maladie.

✘ **Item C** → *Il est facile de faire de la prévention sur les maladies chroniques*

Pas tout à fait… Ici aussi il ne faut pas confondre avec les maladies infectieuses. Pour les maladies chroniques, la prévention n'est pas facile car elles résultent de multiples facteurs tandis qu'en théorie, la prévention des maladies infectieuses est facile car l'agent causal peut être ciblé par des actions de prévention.

✔ **Item D** → *La survenue d'un infarctus du myocarde peut résulter de plusieurs facteurs …*

Une petite liste à lire mais tout est vrai ! Ce sont bien la plupart des facteurs contributifs à la survenue de l'infarctus du myocarde ! Pour compléter, vous pouvez retenir que le risque de survenue augmente lorsque l'on cumule plusieurs de ces facteurs.

✘ **Item E** → *Le stress et l'obésité ne peuvent pas contribuer à la survenue d'une maladie chronique*

Non ! Par exemple dans le cas de l'infarctus du myocarde, si un patient à également de l'obésité, ce facteur augmente le risque d'infarctus du myocarde. Idem pour un patient stressé qui sera plus enclin à développer la maladie si plusieurs facteurs sont cumulés.

Réponses vraies : A et D

Question 25
Concernant la classification des facteurs de risque, parmi les propositions suivantes, laquelle ou (lesquelles) est (sont) exactes ?

A. Les facteurs biologiques et physiques sont des facteurs de risque endogènes car ils sont directement liés à l'hôte

B. L'activité physique est un facteur endogène car il est lié au comportement de l'hôte

C. La prise de médicaments est un facteur endogène

D. Les facteurs socio-économiques prennent en compte le niveau d'étude et les catégories socioprofessionnelles (CSP)

E. Le stress et la dépression sont des facteurs de risque exogènes

Question 25

✘ **Item A** → *Les facteurs biologiques et physiques sont des facteurs de risque endogènes car ils …*

Aïe… Petit item méchant car on peut penser qu'il est vrai. Cependant, lorsque l'on parle de facteurs biologiques, on parle par exemple des **bactéries ou du pollen** et donc de facteurs extrinsèques à l'hôte. Idem pour les facteurs physiques qui font référence à des facteurs tels que **l'exposition au bruit** (subi ou choisi) ou les rayonnements ionisants. Les facteurs biologiques et physiques sont donc des facteurs exogènes.

✔ **Item B** → *L'activité physique est un facteur endogène car il est lié au comportement de l'hôte*

C'est tout à fait ça ! C'est l'un des exemples de votre cours liés aux facteurs de risque endogènes par l'intermédiaire du comportement du patient ! L'activité physique est un facteur protecteur vis-à-vis de la récidive d'infarctus du myocarde et diminue le risque de moitié grâce à la pratique d'une activité physique légère à modérée.

✔ **Item C** → *La prise de médicaments est un facteur endogène*

C'est exact ! La prise de médicaments et les accidents sont des **facteurs de risque intrinsèques (= endogènes)** car ils proviennent du comportement du patient et non pas de facteurs liés à l'environnement.

✔ **Item D** → *Les facteurs socio-économiques prennent en compte le niveau d'étude et les …*

Ouiiii tout à fait ! On peut ainsi relier le niveau d'étude avec la mortalité relative (plus le niveau d'études déclaré est élevé, plus la mortalité relative est faible) et l'espérance de vie avec les CSP (plus la CSP est élevée, plus l'espérance de vie est élevée).

✔ **Item E** → *Le stress et la dépression sont des facteurs de risque exogènes*

Ouiiii ! Ils rentrent dans les facteurs psychologiques. Par exemple, la prévalence d'infarctus du myocarde est multipliée par 2 chez les personnes exposées à un stress permanent au travail par rapport aux non-exposées.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 26
Un million de personnes ont été suivies pendant 30 ans afin d'étudier la survenue d'une pathologie M. 200 000 personnes ont été exposées à un agent infectieux F. 800 000 personnes n'ont pas été exposées à F. Parmi les exposés, 500 ont développé la pathologie M ; chez les non-exposés, 200 l'ont développée. Parmi les propositions suivantes, indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s).

A. Le risque de développer la pathologie M chez les exposés à F est de 2,5 pour 1000

B. Le risque de développer la pathologie M chez les non exposés est de 20 pour 1000

C. Le risque relatif pour la pathologie M en relation avec l'exposition à F est de 20

D. Le risque de pathologie M attribuable à l'exposition à F est de 225 pour 100 000

E. La fraction étiologique de M liée à F chez les exposés à F est de 60%

Question 26

✔ **Item A** → *Le risque de développer la pathologie M chez les exposés à F est de 2,5 pour 1000*

Ouiii ! Le risque de développer la pathologie M chez les exposés à F est :

$$P(M/F) = \frac{500}{200000} = 0{,}0025 = \mathbf{2{,}5\ pour\ 1000}$$

✘ **Item B** → *Le risque de développer la pathologie M chez les non exposés est de 20 pour 1000*

Attention ! Le risque de développer la pathologie M chez les non exposés est :

$$P(M/\bar{F}) = \frac{200}{800000} = 0{,}00025 = \mathbf{0{,}25\ pour\ 1000}$$

✘ **Item C** → *Le risque relatif pour la pathologie M en relation avec l'exposition à F est de 20*

Non ! Le risque relatif pour la pathologie en relation avec l'exposition à F s'écrit :

$$RR = \frac{P(M/F)}{P(M/\bar{F})} = \frac{0{,}0025}{0{,}00025} = \frac{2{,}5}{0{,}25} = \mathbf{10}$$

✔ **Item D** → *Le risque de pathologie M attribuable à l'exposition à F est de 225 pour 100 000*

Ouiii ! Le risque de pathologie M attribuable à l'exposition à F est :

$$P(M/F) - P(M/\bar{F}) = 0{,}0025 - 0{,}00025 = 0{,}00225 = \mathbf{225\ pour\ 100000}$$

✘ **Item E** → *La fraction étiologique de M liée à F chez les exposés à F est de 60%*

Aïe aïe aïe… $f = \frac{P(M/F)-P(M/\bar{F})}{P(M/F)} = \frac{0{,}0025-0{,}00025}{0{,}0025} = \frac{0{,}00225}{0{,}0025} = \mathbf{90}\%$
Les calculs ne sont pas faciles et prennent beaucoup de temps ! Entraînez vous +++ et à la fin vous réussirez ces questions comme des chefs !!!! Bon courage pour la suite de la correction !

Réponses vraies : A et D

Question 27
Concernant les facteurs de risque, laquelle (lesquelles) de ces réponses est (sont) exacte(s) ?

A. Pour mettre en évidence un lien de causalité, on peut simplement accumuler des preuves

B. En épidémiologie de population, on privilégie l'approche expérimentale

C. La force de l'association est un critère de Hill

D. La taille de la population exposée au facteur de risque et touchée par la maladie constitue un critère de Hill

E. La constance et la reproductibilité est un critère de Hill

Question 27

✔ **Item A** → *Pour mettre en évidence un lien de causalité, on peut simplement accumuler des …*

Et oui ! Ne vous laissez pas avoir par la formulation. Démontrer une causalité est impossible : on peut uniquement accumuler des preuves.

✘ **Item B** → *En épidémiologie de population, on privilégie l'approche expérimentale*

Tout l'inverse… Cette approche est au contraire difficilement envisageable (d'un point de vue éthique notamment).

✔ **Item C** → *La force de l'association est un critère de Hill*

Exact !! On vous donne comme exemple dans le cours la relation entre le tabac et le cancer du poumons : les fumeurs ont beaucoup plus de risque de développer un cancer du poumon que les non fumeurs.

✘ **Item D** → *La taille de la population exposée au facteur de risque et touchée par la maladie …*

Vous avez peut-être reconnu à l'explication bancale que c'était faux. En effet, ce n'est pas parce que toutes les personnes décédées ont bu de l'eau que celle-ci est un facteur de risque…

✔ **Item E** → *La constance et la reproductibilité est un critère de Hill*

Ouiii, ça fait ma configuration de réponse préférée hihi (ACE) (vous aussi vous en aurez une).
Petit rappel sur les 7 critères de Hill :

- Force de l'association
- Existence d'une relation entre la dose et l'effet
- Existence d'une relation temporelle entre F et M
- Suppression du facteur faisant diminuer l'incidence
- Argument de constance et de reproductibilité
- Plausibilité biologique
- Compatibilité et cohérence

Fin de la liste 😄.

Réponses vraies : A, C et E

Question 28
Concernant l'étude des facteurs de risque, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La première approche part de la maladie pour rechercher les facteurs qui la favorisent

B. La deuxième approche part de la maladie pour rechercher les facteurs qui la favorisent

C. Une population à risque est un ensemble de personnes qui accumulent les facteurs péjoratifs

D. Les populations à risque ne bénéficient pas d'une surveillance accrue car celle-ci pourrait être considérée comme discriminatoire

E. La deuxième approche permet la définition d'une population à risque

Question 28

✔ **Item A** → *La première approche part de la maladie pour rechercher les facteurs qui la favorisent*

On commence par un item vrai : la première approche part d'une maladie et recherche l'ensemble des facteurs qui la favorisent, contrairement à la deuxième approche qui part d'un facteur donné et étudie les différentes maladies qui lui sont associées.

✘ **Item B** → *La deuxième approche part de la maladie pour rechercher les facteurs qui la favorisent*

C'est l'inverse 😛 (cf. Item A).

✔ **Item C** → *Une population à risque est un ensemble de personnes qui accumulent les facteurs ...*

Exactement !

✘ **Item D** → *Les populations à risque ne bénéficient pas d'une surveillance accrue car celle-ci ...*

Non ! La surveillance accrue des populations à risque permet justement de lutter contre les situations qui génèrent une accumulation de facteurs de risque.

✘ **Item E** → *La deuxième approche permet la définition d'une population à risque*

Et non, c'est la première approche qui permet la définition d'une population à risque !

Réponses vraies : A et C

Question 29
Les 200 000 habitants d'une ville ont été suivis sur 15 ans afin d'étudier la survenue d'une maladie M. Au sein de ce groupe, 80 000 personnes ont été exposées à un facteur F et 120 000 personnes n'y ont pas été exposées. Parmi les exposés, 6 400 ont développé la maladie M tandis que chez les non exposés, 2 400 l'ont développée. Concernant les différents types de risque, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le risque attribuable est de 0,06

B. Le risque relatif est de 0,06

C. Le risque relatif est de 0,4

D. La formule de la fraction étiologique du risque chez les exposés liée à un facteur F est :

$$f = \frac{RA}{P(M)}$$

E. La fraction étiologique de la maladie M liée au facteur F chez les exposés est de 0,75

Question 29

✔ **Item A** → *Le risque attribuable est de 0,06*

Tout juste ! Le risque attribuable au facteur F est :

$$RA = P(M/F) - P(M/\bar{F}) = 0{,}08 - 0{,}02 = \mathbf{0{,}06}$$

.

✘ **Item B** → *Le risque relatif est de 0,06*

Et non, le risque relatif pour la maladie M en relation avec l'exposition au facteur F est :

$$RR = \frac{P(M/F)}{P(M/\bar{F})} = \frac{0{,}08}{0{,}02} = \mathbf{4}$$

.

✘ **Item C** → *Le risque relatif est de 0,4*

Toujours pas ! Le risque relatif est bien de **4** et non 0,4. La question est un peu méchante (désolée 😖), faîtes bien attention à vérifier vos résultats et à bien lire les items pour éviter les erreurs d'inattention.

✘ **Item D**

Attention aux détails ! Il s'agit de la formule de la fraction étiologique du risque liée au facteur F **en population générale**. La formule de la fraction étiologique du risque liée au facteur F **chez les exposés** est :

$$f = \frac{RA}{\mathbf{P(M/F)}}$$

.

✔ **Item E** → *La fraction étiologique de la maladie M liée au facteur F chez les exposés est de 0,75*

Oui !!! Nous avons vu à l'item D la formule de la fraction étiologique du risque liée au facteur F chez les exposés :

$$f = \frac{RA}{P(M/F)} = \frac{0{,}06}{0{,}08} = \mathbf{0{,}75}$$

Retenez bien les formules et entraînez-vous +++. Bon courage 😉 !

Réponses vraies : A et E

Question 30
Parmi les propositions suivantes concernant cette figure et vos propres connaissances, indiquez laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)

Tableau 3

Nombre total de décès, fraction et nombre attribuables à l'alcool, par sexe et cause détaillée de décès, en France métropolitaine en 2015 (adultes de plus de 15 ans)

Cause de décès	Hommes			Femmes			Total		
	Décès	Fraction attribuable (%)	Décès attribuable	Décès	Fraction attribuable (%)	Décès attribuable	Décès	Fraction attribuable (%)	Décès attribuable
Cancer	**91 133**	**13,6**	**12 358**	**67 532**	**5,3**	**3 573**	**158 665**	**10,0**	**15 931**
Bouche	1 188	78,1	927	547	37,1	203	1 735	65,1	1 130
Pharynx	1 764	78,2	1 380	367	39,0	143	2 131	71,5	1 523
Œsophage	2 970	75,6	2 245	871	39,3	342	3 841	67,4	2 587
Côlon et rectum	9 178	30,4	2 791	7 828	8,2	645	17 006	20,2	3 436
Foie	6 100	73,7	4 499	2 300	17,1	394	8 400	58,2	4 893
Larynx	918	56,2	516	157	21,7	34	1 075	51,2	550
Sein	_	_	_	12 294	14,7	1 812	_	_	_
Maladie cardiovasculaire	**65 651**	**8,9**	**5 872**	**76 232**	**5,3**	**4 025**	**141 883**	**7,0**	**9 897**
Maladie hypertensive	3 643	30,3	1 105	6 700	13,8	924	10 343	19,6	2 029
Cardiopathie ischémique	19 798	1,3	257	13 620	2,3	314	33 418	1,7	571
Cardiomyopathie alcoolique	77	100	77	18	100	18	95	100	95
Arythmie cardiaque	2 749	51,9	1 426	3 120	21,1	659	5 869	35,5	2 085
Accident vasculaire cérébral hémorragique	6 466	32,8	2 124	8 499	21,5	1 830	14 965	26,4	3 954
Accident vasculaire cérébral ischémique	5 981	13,4	801	9 486	2,7	254	15 467	6,8	1 055
Varices œsophagiennes	82	100	82	26	100	26	108	100	108
Maladie digestive	**12 464**	**39,7**	**4 951**	**10 935**	**16,7**	**1 829**	**23 399**	**29,0**	**6 780**
Gastrite alcoolique	1	100	1	0	100	0	1	100	1
Maladie alcoolique du foie	3 164	100	3 164	1 053	100	1 053	4 217	100	4 217
Hépatite chronique sans précision	14	100	14	6	100	6	20	100	20
Fibrose et cirrhose du foie	1 781	100	1 781	785	100	785	2566	100	2566
Cholélithiase	147	– 45,6	– 67	223	– 9,0	– 20	370	– 23,5	– 87
Pancréatite	83	69,9	58	23	21,7	5	106	59,4	63
Externes (accidents et suicides)	**22 219**	**20,5**	**4 562**	**15 518**	**6**	**870**	**37 737**	**14**	**5 432**
Autres maladies	**82 993**	**3,1**	**2 607**	**107 090**	**0,4**	**433**	**190 083**	**1,6**	**3 040**
Diabète de type 2	3 877	2,9	114	3 921	– 5,6	– 221	7 798	– 1,4	– 107
Encéphalopathie de Wernicke	7	100	7	5	100	5	12	100	12
Maladie mentale due à l'alcool	1 994	100	1 994	496	100	496	2 490	100	2 490
Dégénérescence du système nerveux due à l'alcool	44	100	44	11	100	11	55	100	55
Épilepsie et mal épileptique	818	53,2	435	786	17,7	139	1 604	35,8	574
Polynévrite alcoolique	13	100	13	3	100	3	16	100	16
Total	**287 198**	**10,6**	**30 350**	**288 844**	**3,7**	**10 730**	**576 042**	**7,1**	**41 080**

A. On compte plus de décès attribuables à l'alcool chez les patients souffrant de maladie mentale liée à l'alcool que chez ceux atteints de fibrose et de cirrhose du foie

B. Le nombre de décès lié à des causes externes (accidents et suicides) est égal à 22 219 en 2015

C. 34 décès sont attribuables à l'alcool chez les femmes décédées d'un cancer du larynx

D. Les hommes sont davantage atteints de maladies digestives par rapport aux femmes

E. Chez les hommes décédés d'une arythmie cardiaque, environ un décès sur deux est imputable à la consommation d'alcool

Question 30

❌ **Item A** → *On compte plus de décès attribuables à l'alcool chez les patients souffrant de maladie ...*

Et nonnn 😛 ! Attention dans ce genre de tableau à bien prendre son temps (mais pas trop hein) pour savoir quelle information chercher. Ici, comme on indique pas de genre, c'est sur la colonne **total** (à droite) que l'on va s'appuyer :

- En ce qui concerne les décès par *maladie mentale due à l'alcool*, on observe que **2490** d'entre eux sont imputables à l'alcool.
- Quant aux décès par *fibrose et cirrhose du foie*, on compte parmi ceux-là **2566 décès** qui sont attribués à l'alcool.

2490<2566
Ainsi, on peut invalider cet item !!

❌ **Item B** → *Le nombre de décès lié à des causes externes (accidents et suicides) est égal à 22 ...*

Aïe aïe aïe... On retrouve bien cette info dans notre tableau, mais chez les hommes ! Or l'énoncé ne fait aucune précision de genre à nouveau. Dans la bonne colonne, il fallait trouver **37 737** !

✔️ **Item C** → *34 décès sont attribuables à l'alcool chez les femmes décédées d'un cancer du larynx*

Tout à fait, continuez comme ça 💫 !!

❌ **Item D** → *Les hommes sont davantage atteints de maladies digestives par rapport aux femmes*

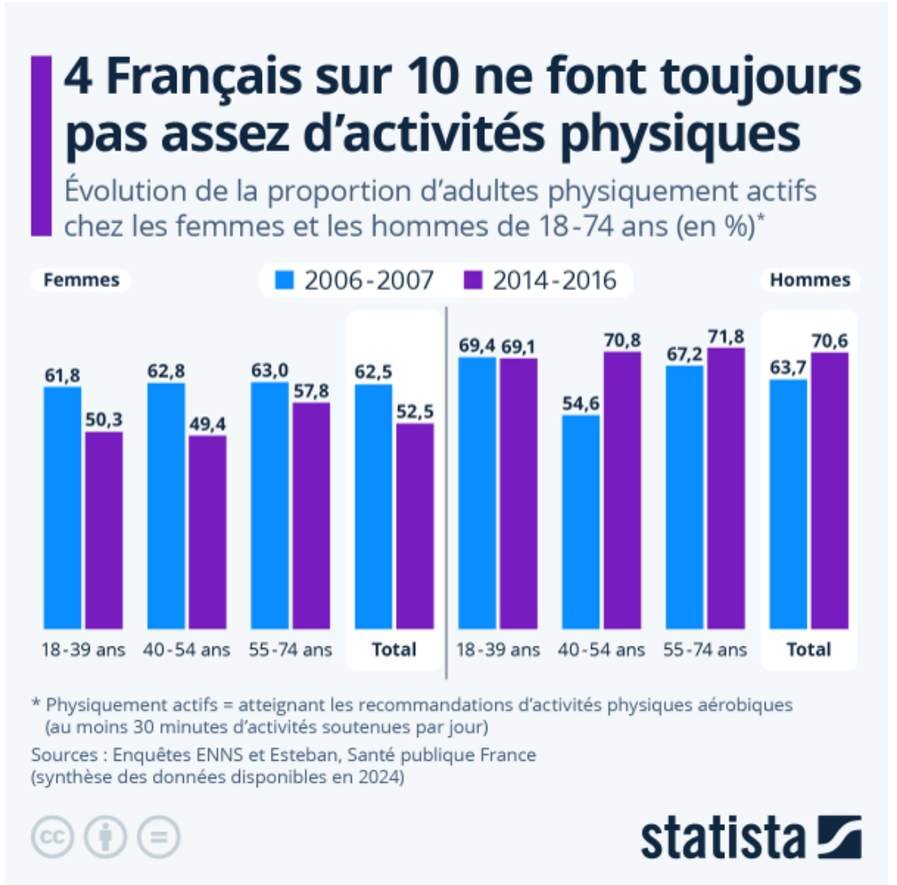
Est-ce qu'on voit ce genre d'info une fois dans notre tableau ?? NON, donc on invalide ça de suite 🏃 !

✔️ **Item E** → *Chez les hommes décédés d'une arythmie cardiaque, environ un décès sur deux est ...*

Et ouais bravo !! Il suffit de voir que la fraction de décès attribuables à l'alcool chez les hommes décédés d'une arythmie cardiaque est égale à **51,9%** pour affirmer cela. Bon courage les boss 🔥 !!

Réponses vraies : C et E

Question 31
Parmi les propositions suivantes concernant cette figure et vos propres connaissances, indiquez laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s).



A. La proportion de femmes physiquement actives a diminué de 10 points de pourcentage entre les deux périodes

B. Entre les deux périodes, la proportion d'hommes physiquement actifs a augmenté de façon homogène dans toutes les tranches d'âge

C. La proportion de femmes physiquement actives âgées de 55 à 74 ans diminue entre les deux périodes étudiées

D. Au cours de la période 2014-2016, plus de la moitié des femmes de 40-54 ans n'atteignent pas les recommandations d'au moins 30 minutes d'activités soutenues par jour

E. En 2009, l'inactivité physique a été identifiée comme étant le troisième facteur de risque des maladies non transmissibles

Question 31

✔ **Item A** → *La proportion de femmes physiquement actives a diminué de 10 points de…*

Ouiii, on voit bien qu'entre les deux périodes, on passe de **62,5%** de femmes physiquement actives à **52,5%**, ce qui correspond bien à une baisse de 10%.

✘ **Item B** → *Entre les deux périodes, la proportion d'hommes physiquement actifs a augmenté…*

C'est faux ! On ne voit pas d'augmentation dans toutes les tranches d'âges, puisque l'activité physique baisse légèrement chez les 18-39 ans, passant de 69,4 à 69,1%. On se dépêche d'invalider cet item !!

✔ **Item C** → *La proportion de femmes physiquement actives âgées de 55 à 74 ans diminue entre…*

Oui ! On passe de 63 à 57,8% de femmes de 55 à 74 ans physiquement actives, ce qui correspond bien à une diminution.

✔ **Item D** → *Au cours de la période 2014-2016, plus de la moitié des femmes de 40-54 ans…*

Tout à fait ! En 2014-2016, seules 49,4% des femmes de 40-54 ans sont physiquement actives, donc : 100 - 49,4 = **50,6%** n'atteignent pas les recommandations.

✘ **Item E** → *En 2009, l'inactivité physique a été identifiée comme étant le troisième facteur de…*

Presque, c'est le quatrième !

Réponses vraies : A, C et D

Question 32
Concernant les conséquences sanitaires du tabagisme, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Il n'y a pas de seuil en-dessous duquel fumer ne représente pas de risque
B. Le tabagisme passif peut causer une insuffisance respiratoire chronique, des infections bronchiques ou de l'asthme
C. Le tabagisme actif augmente le risque de fausse couche de 35%
D. Le tabagisme passif n'impacte pas le foetus
E. Le sexe ratio du tabagisme est de 30 femmes pour 10 hommes

Question 32

✔ **Item A** → *Il n'y a pas de seuil en-dessous duquel fumer ne représente pas de risque*

Exact !! Phrase écrite noir sur blanc dans le cours. C'est-à-dire que, dès la moindre petite cigarette fumée, on ne peut plus jamais revenir à notre niveau de risque d'avant cette cigarette. Chaque cigarette est toxique, même si c'est une seule et une seule fois !

✔ **Item B** → *Le tabagisme passif peut causer une insuffisance respiratoire chronique, des…*

Ouii ! Petit rappel : pour le tabagisme ACTIF, j'inhale la fumée de la cigarette que je fume et pour le tabagisme PASSIF, j'inhale de manière fréquente et répétée la fumée des cigarettes fumées autour de moi.

✘ **Item C** → *Le tabagisme actif augmente le risque de fausse couche de 35%*

Aie non j'ai tout mélangé… Le tabagisme actif a de multiples impacts sur la grossesse, mais il est **responsable de 35% des grossesses extra-utérines** d'une part et **multiplie le risque de fausse couche par 3** d'autre part.

✘ **Item D** → *Le tabagisme passif n'impacte pas le foetus*

Siii malheureusement… Il nuit à toutes les catégories d'âge : adulte, jeune enfant, nourrisson et même foetus ! On peut retrouver des malformations congénitales, une diminution des capacités cognitives ou encore un petit poids de naissance.

✘ **Item E** → *Le sexe ratio du tabagisme est de 30 femmes pour 10 hommes*

Item faux car le nombre d'hommes et de femmes est inversé ! Il faudrait mettre 30 hommes pour 10 femmes.

Réponses vraies : A et B

Question 33
Concernant les addictions, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les addictions avec substance concernent le tabac (nicotine), l'alcool, le cannabis, les opiacés (héroïne, morphine), la cocaïne, les amphétamines et les dérivés de synthèse
B. L'OMS donne la définition suivante : « l'addiction est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou des comportements »
C. On peut prévenir 50% des cas de cancer grâce à des changements de comportements et de mode de vie
D. La classification nationale inclut notamment les notions de perte de contrôle de soi, l'interférence de la consommation sur les activités scolaires ou professionnelles, la poursuite de la consommation malgré la conscience des troubles provoqués
E. Les addictions sans substance concernent le jeu pathologique (gaming disorder) et les jeux vidéo (gambling disorder)

Question 33

✔ **Item A** → *Les addictions avec substance concernent le tabac (nicotine), l'alcool, le cannabis,…*

C'est exactement ça !

✔ **Item B** → *L'OMS donne la définition suivante : « l'addiction est un état de dépendance…*

Là encore c'est vrai ! Pensez à bien apprendre les définitions en SP 😉.

✘ **Item C** → *On peut prévenir 50% des cas de cancer grâce à des changements de comportements…*

On peut prévenir **40%** des cas de cancer et non 50% mais c'est déjà beaucoup !

✘ **Item D** → *La classification nationale inclut notamment les notions de perte de contrôle de soi, ...*

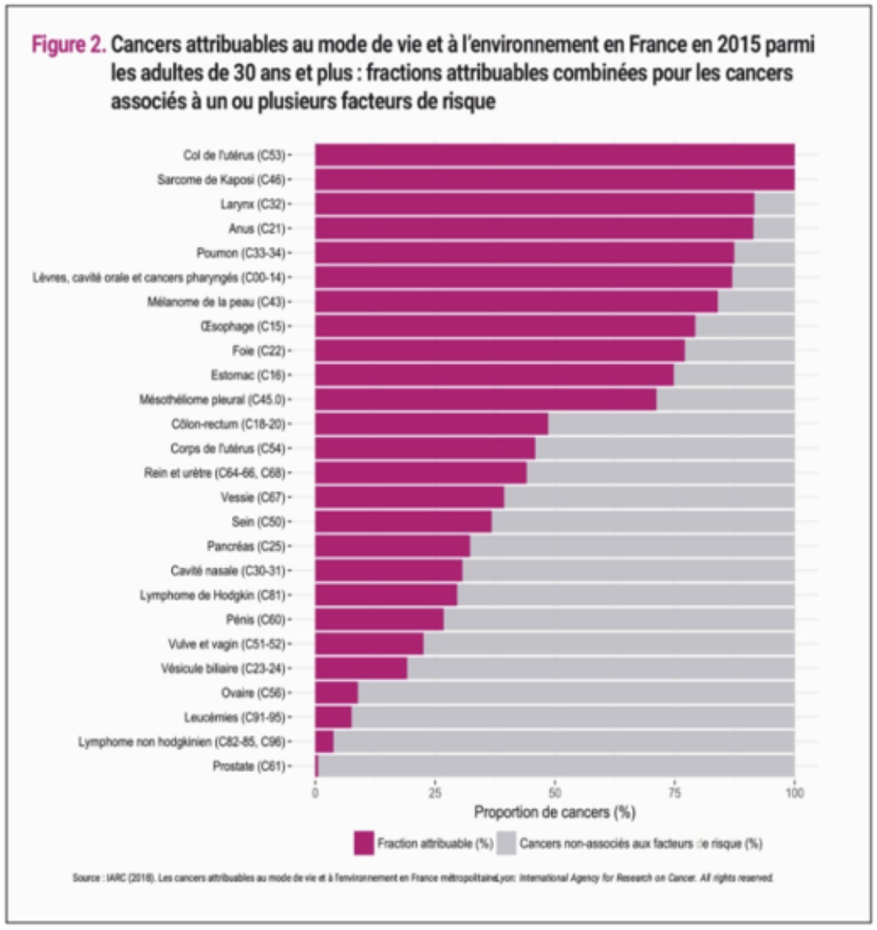
C'est la classification **internationale**, attention aux détails 😉 !

✘ **Item E** → *Les addictions sans substance concernent le jeu pathologique (gaming disorder) et ...*

Le jeu pathologique est appelé "gambling disorder" et l'addiction aux jeux vidéo "gaming disorder". L'item est un peu piégeur mais il faut vraiment bien faire attention aux petits détails.

Réponses vraies : A et B

Question 34
D'après vos connaissances et par lecture du graphique, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. La fraction attribuable au mode de vie et à l'environnement en France en 2015 des cancers de l'œsophage est supérieure à la proportion de cancers du larynx non-associés aux facteurs de risque en France en 2015, chez les adultes de plus de 30 ans

B. Dans la majorité des cas, le cancer du sein est attribuable au mode de vie et à l'environnement en France en 2015 chez les adultes de plus de 30 ans

C. Un cancer sur quatre est lié au tabagisme

D. Le nombre de cancers de la prostate attribuables au mode de vie et à l'environnement est inférieur au nombre de sarcomes de Kaposi attribuables au mode de vie et à l'environnement en 2015 en France chez les adultes de plus de 30 ans

E. Près de 50% des cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France en 2015 parmi les adultes de 30 ans et plus sont les cancers du côlon-rectum

Question 34

✔ **Item A** → *La fraction attribuable au mode de vie et à l'environnement en France en 2015 des…*

Alambiqué l'item, mais si on le décortique bien, c'est tout bon ! On nous parle de la fraction attribuable au mode de vie et à l'environnement des cancers de l'œsophage. Sur le graphique, on lit que ça fait en gros 80%. Puis on nous parle de la proportion de cancers du larynx **non**-associés aux facteurs de risque, donc c'est la partie grise du graphique. Cette proportion est à peu près de 10%. Or, 80>10 donc l'item est vrai !

✘ **Item B** → *Dans la majorité des cas, le cancer du sein est attribuable au mode de vie et à…*

Alors alors, cancer du sein tac tac tac je cherche la ligne, je regarde le pourcentage au bout de la barre rose, c'est à peu près **35-40%**, donc c'est moins de la majorité !

✘ **Item C** → *Un cancer sur quatre est lié au tabagisme*

Tiens tiens, une question de cours qui se glisse dans une question sur un graphique… Bon par contre donnée à savoir c'est 1 cancer sur **3** qui est lié au tabagisme, et ce ne sont pas que des cancers du poumon ! Il y a aussi les cancers de la gorge, de la bouche, du pancréas, du rein, de la vessie et de l'utérus qui sont concernés.

✘ **Item D** → *Le nombre de cancers de la prostate attribuables au mode de vie et à…*

Ouille non ! En **fraction attribuable oui, mais pas en nombre total**… Vous n'avez pas à le savoir, mais le graphique ne permet pas de l'affirmer, donc non !

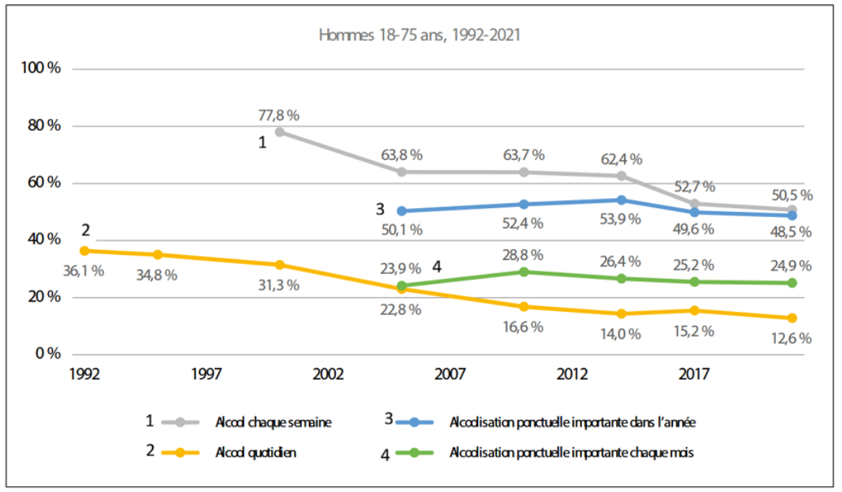
✘ **Item E** → *Près de 50% des cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France…*

Oula, j'ai tout whippin !!! L'affirmation correcte aurait été : "près de 50% des cancers du côlon-rectum sont attribuables au mode de vie et à l'environnement".

Réponse vraie : A

Question 35
D'après vos connaissances et par lecture du graphique, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

Figure 1 – Évolution des modes de consommation d'alcool chez les hommes en France hexagonale



Source : *Baromètre* de Santé publique France, éditions 1992-2021.

A. Chez les hommes, l'alcoolisation ponctuelle importante dans la semaine a diminué entre 2002 et 2017

B. En 2012, le pourcentage d'hommes consommant de l'alcool quotidiennement est inférieur au pourcentage d'hommes consommant de l'alcool chaque semaine

C. En 1992, le pourcentage d'hommes consommant de l'alcool quotidiennement était à son maximum sur la période 1992-2021

D. En 2017, environ 25% des hommes déclarent avoir une alcoolisation ponctuelle importante chaque mois

E. La consommation d'alcool, comme le sommeil ou l'alimentation sont des facteurs endogènes modifiables

Question 35

✘ **Item A** → *Chez les hommes, l'alcoolisation ponctuelle importante dans la semaine a diminué…*

Et non… 😕. On ne nous parle pas d'alcoolisation ponctuelle importante dans la semaine sur ce graphique, on n'a des infos que sur l'alcoolisation ponctuelle importante **dans l'année** ou **chaque mois**.

✔ **Item B** → *En 2012, le pourcentage d'hommes consommant de l'alcool quotidiennement est…*

Oui oui ! Si on prend le temps de bien regarder le graphique, on trouve bien ça ! Il faut comparer les courbes 1 et 2 😉.

✔ **Item C** → *En 1992, le pourcentage d'hommes consommant de l'alcool quotidiennement était…*

Mais ouiiii c'est çaaaaa : le pourcentage d'alcool quotidien (courbe 2) atteint un **maximum en 1992** avec **36,1%**.

✔ **Item D** → *En 2017, environ 25% des hommes déclarent avoir une alcoolisation ponctuelle…*

Alors… Alcoolisation importante chaque mois, c'est la courbe numéro 4, on nous parle de 2017, je regarde et c'est 25,2%, c'est bien environ 25% !

✔ **Item E** → *La consommation d'alcool, comme le sommeil ou l'alimentation sont des facteurs…*

Hop petite question de cours ! Les facteurs endogènes modifiables sont des facteurs qui concernent directement l'individu (ça peut changer d'une personne à l'autre dans une même maison) et sur lequel l'individu peut agir (donc pas sa génétique par exemple). La consommation d'alcool, le sommeil et l'alimentation en font partie !

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 36
Concernant les facteurs de risques comportementaux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'activité physique se définit comme "tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques et qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à la dépense de repos"

B. L'inactivité physique est un synonyme de la sédentarité

C. En 2009, l'inactivité physique a été identifiée comme étant le quatrième facteur de risque des maladies transmissibles

D. L'inactivité physique est responsable dans le monde de 7% du diabète de type 2 et de 10% des cancers du côlon

E. Le fait de passer plus de 3 heures par jour en position assise serait responsable de 6,8% de la mortalité toutes causes

Question 36

✔ **Item A** → *L'activité physique se définit comme "tout mouvement corporel produit par la…*

C'est exactement la définition d'activité physique !

✘ **Item B** → *L'inactivité physique est un synonyme de la sédentarité*

NAAAN la sédentarité est différente de l'inactivité physique ! Je vous remets la slide du cours pour bien comprendre.

Université Paris Cité

Définitions

Sédentarité

La sédentarité se définit par tout comportement caractérisé par une dépense énergétique inférieure à 1,6 METs (Équivalent métabolique ou Metabolic Equivalent Task) incluant la position assise ou allongée.

Elle est à considérer de manière indépendante de l'(in)activité physique. Il est possible d'être physiquement actif tout en accumulant des comportements sédentaires et ce, sur une même journée.

La sédentarité est ainsi un facteur de risque spécifique des maladies non transmissibles qui se surajoute à l'inactivité physique.

Diapo 26 - Cours 5 - Pr. Corinne Alberti

✘ **Item C** → *En 2009, l'inactivité physique a été identifiée comme étant le quatrième facteur de…*

ATTENTION !!! Il ne faut pas lire trop vite : en 2009, l'inactivité physique a été identifiée comme étant le quatrième facteur de risque des maladies **NON** transmissibles. Pour compléter elle est impliquée dans plus de 3 millions des morts évitables.

✔ **Item D** → *L'inactivité physique est responsable dans le monde de 7% du diabète de type 2 et…*

Exact. Je vous remets la liste avec les pourcentages.

L'inactivité physique est responsable dans le monde :
- 6 à 9% de la mortalité toutes causes
- 6% des maladies coronariennes
- 7% du diabète de type 2
- 10% des cancers du sein
- 10% des cancers du côlon
- 9% des morts prématurées seraient attribuables au seul fait d'être inactif

Diapo 26 - Cours 5 - Pr. Corinne Alberti

✘ **Item E** → *Le fait de passer plus de 3 heures par jour en position assise serait responsable de…*

Oupsi, petit piège sur le pourcentage ! C'est 3,8%.

Réponses vraies : A et D

Question 37
Concernant les facteurs de risques comportementaux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraies ?

A. La nutrition est uniquement un facteur de risque des maladies non transmissibles en France
B. D'après l'étude ESTEBAN de 2014-2015 sur les consommations alimentaires, les inégalités sociales de consommation diminuent grâce aux modifications d'alimentation des catégories les moins diplômées
C. D'après l'étude ESTEBAN de 2014-2015 sur les consommations alimentaires, les adultes consomment dans l'ordre croissant trop de produits sucrés, puis trop de charcuterie, puis trop de sel
D. Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a été mis en place en janvier 2001 pour améliorer la situation nutritionnelle des plus défavorisés
E. Les objectifs du PNNS répondent à 6 axes dont l'augmentation de l'activité physique et la diminution de la sédentarité à tous les âges

Question 37

✘ **Item A** → *La nutrition est uniquement un facteur de risque des maladies non transmissibles ...*

Quand on pense à la nutrition, on se souvient que certes elle peut aggraver notre état de santé (alimentation déséquilibrée, trop grasse, sucrée...) mais qu'elle peut aussi l'améliorer ! Tout dépend du régime alimentaire. C'est donc à la fois un facteur de risque et un facteur protecteur !

✘ **Item B** → *D'après l'étude ESTEBAN de 2014-2015 sur les consommations alimentaires, les ...*

Toujours bien faire attention aux derniers mots d'un item !! C'est le fait que les **plus** diplômés modifient leur alimentation qui réduit l'écart ! En effet, ce n'est pas écrit explicitement dans le cours mais ce rapprochement est lié à la dégradation des habitudes alimentaires des plus diplômés plutôt qu'à une amélioration de celles des moins diplômés. On peut l'expliquer par des contraintes professionnelles qui favorisent le grignotage ou les aliments ultra-transformés qui laissent moins de temps pour préparer ses repas maison...

✔ **Item C** → *D'après l'étude ESTEBAN de 2014-2015 sur les consommations alimentaires, les ...*

Enfin un item bon ouffff ! Et puis il est long quoi !

✘ **Item D** → *Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a été mis en place en janvier 2001 ...*

Oups non ce genre de programme constitue une prévention globale, qui concerne la population générale, et pas une prévention ciblée, qui vise des groupes sociaux en particulier ! L'indice c'est le fait qu'il y ait "National" dans le nom du plan 😉.

✘ **Item E** → *Les objectifs du PNNS répondent à 6 axes dont l'augmentation de l'activité physique ...*

Alors oui c'est en effet un objectif du PNNS maiiiis il y a 4 axes en tout, pas 6 ! Il vaut mieux le savoir, et connaître chaque axe aussi. BRAVOOO d'être arrivés jusqu'à la fin de cette correction de tuto 1 waouh ! Je suis choquée vous êtes trop persévérants 😈. La SP c'est un poulet en vrai, prenez du plaisir à apprendre les cours, elle vous le rendra, promis !

Réponse vraie : C

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Manon NORDMANN (LAS2 MedPhy), Diana ALAMI (LAS2 SIAS), Faustine JEANJEAN (DFGSM2), Agathe Serrier (DFGSM2), Iyas OUERTANI (DFGSM2, aka le boss des tuteurs), Kashthuri BALACHANDRAN (DFGSMa2), Loan NGUYEN (DFGSM2, RM SP PASS 2026-2027), Maxime ZHANG (DFGSM2, frère d'Alicia + RM EB PASS Biocell 2026-2027), Mayssam TRIKI (DFGSP2, tutrice), May ABDEL DAYEM (L1 eco - SES), Mously LEYE (DFGSO2)

Relecteurs :

Manon NORDMANN (LAS2 MedPhy), Diana ALAMI (LAS2 SIAS), Faustine JEANJEAN (DFGSM2), Ron SHAFIR (LAS 2 Sciences Biomédicales), Lou DOUDEAU (DFGSMa2), Mayssam TRIKI (DFGSP2), May ABDEL DAYEM (L1 eco - SES), Mously LEYE (DFGSO2), Marjorie GOETZMANN (DFGSM2), Lucian DANGREMONT (DFGSO2, RM PASS HE 2026-2027), Loan NGUYEN (DFGSM2, RM SP PASS 2026-2027), Djéhane MAHRAZI (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :

Lilian POV (LAS 2 Biomed), Loan NGUYEN (DFGSM2 supplément RM SP PASS 2026-2027)

Testeurs :

Loan NGUYEN (DFGSM2 sauce RM SP PASS 2026-2027)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Massiva ADRAR (DFGSP2) et Alicia ZHANG (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team SPeculoos**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Loan NGUYEN (DFGSM2, RM SP PASS 2026-2027) et Maelys TURPIN (DFGSM3, RM SP PASS 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours	Utilise la loupe 🔍	Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	(en haut à droite)	Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP